

LES ESPRITS PLURIELS

Comprendre la neurodiversité
au-delà des diagnostics et des cases



DES CERVEAUX
DIFFÉRENTS
UN MÊME MONDE

Les Esprits pluriels

*Comprendre la neurodiversité sans réduire les
personnes à un diagnostic*

Daloze Didier

Septembre 2026

<https://www.les-esprits-pluriels.be/>

Sommaire

Avant-propos.....	4
PARTIE I COMPRENDRE LA DIFFÉRENCE.....	7
Chapitre 1. Il n'existe pas un cerveau normal.....	7
Chapitre 2. Quand la différence devient un trouble.....	13
PARTIE II DES DIAGNOSTICS, DES RÉALITÉS MULTIPLES.....	19
Chapitre 3. TDAH : une même étiquette, plusieurs fonctionnements.....	19
Chapitre 4. Autisme : parler d'un spectre sans effacer les personnes.....	25
Chapitre 5. Troubles dys : lorsque l'apprentissage reste coûteux.....	31
Chapitre 6. Haut potentiel, hypersensibilité et zones grises.....	38
Chapitre 7. Profils croisés et comorbidités.....	44
PARTIE III VIVRE AVEC UN FONCTIONNEMENT DIFFÉRENT.....	49
Chapitre 8. Compensation, camouflage et fatigue.....	49
Chapitre 9. L'école : apprendre ou prouver que l'on sait apprendre.....	54
Chapitre 10. Le travail : quand l'organisation rencontre le fonctionnement	60
PARTIE IV SORTIR DES CASES SANS SUPPRIMER LES DIAGNOSTICS.....	66
Chapitre 11. Diagnostiquer sans enfermer.....	66
Chapitre 12. Cartographier un fonctionnement.....	72
Chapitre 13. Penser une société pour plusieurs formes d'esprit.....	80
Quelques repères de vocabulaire.....	85
Repères de lecture des sources.....	88
Bibliographie.....	89

Avant-propos

Les Esprits pluriels part d'une difficulté ordinaire. Deux personnes peuvent recevoir la même consigne, disposer du même temps et produire des résultats très différents. La première semble à l'aise. La seconde s'épuise, s'égare dans les étapes ou réussit au prix d'un effort qui reste invisible. Une troisième échoue dans ce cadre précis et réussit ailleurs. Si l'on s'arrête au résultat, on manque déjà une partie de l'histoire.

Ce livre cherche à comprendre ce qui se joue entre les caractéristiques d'une personne, les exigences d'une situation et les moyens dont elle dispose pour y répondre. Les diagnostics du neurodéveloppement occupent une place importante dans cette enquête parce qu'ils organisent des connaissances cliniques, orientent des évaluations et ouvrent parfois l'accès à des soins ou à des aménagements. Ils ne résument pourtant jamais l'ensemble d'une personne. Deux individus portant le même diagnostic peuvent présenter des capacités, des difficultés, des stratégies et des besoins très différents.

Le mot « neurodiversité » désigne ici la diversité des fonctionnements neurologiques et cognitifs humains. Il porte également, selon les usages, des approches du handicap et des propositions sociales. Ces registres seront distingués tout au long du livre. La diversité n'abolit ni la souffrance ni les besoins de soutien. Elle invite à regarder comment les caractéristiques d'une personne rencontrent les exigences et les appuis de sa vie quotidienne. [1]

La question traverse des gestes très ordinaires. Attendre son tour dans une conversation, retenir une consigne pendant qu'on cherche son matériel, supporter une pièce éclairée toute la journée, comprendre un sous-entendu ou revenir à une tâche interrompue semblent parfois aller de soi. Leur difficulté devient moins mystérieuse lorsque l'on regarde ce que chacun de ces gestes exige. Une grande partie de notre vie commune repose sur des opérations dont nous remarquons surtout l'existence lorsqu'elles cessent d'être faciles.

Les explications choisies orientent directement la réponse. Attribuer la difficulté à un défaut de volonté conduit à demander davantage d'effort. L'expliquer entièrement par l'organisation conduit à interpréter toute persistance comme le signe d'un aménagement insuffisant. Le livre examinera ce que ces lectures laissent de côté. Une explication utile doit rendre compte d'une amélioration réelle, de ses limites et de la part respective des caractéristiques personnelles, des circonstances et des appuis.

La cartographie fonctionnelle sera introduite progressivement pour ordonner des questions sur les tâches, les contextes, les appuis, l'effort et les besoins. Elle restera une proposition descriptive et pédagogique, sans validation clinique propre. Les diagnostics conserveront leur fonction, avec des exigences et des usages qu'une carte personnelle ne peut pas remplacer.

Les situations personnelles utilisées dans le texte sont fictives lorsqu'elles ne renvoient pas à une source publiée. Elles ont été construites pour rendre visibles des mécanismes possibles sans attribuer à un cas imaginaire une valeur de preuve. Les passages consacrés aux connaissances scientifiques distinguent autant que possible les résultats établis, les recommandations professionnelles, les hypothèses et les zones d'incertitude.

Le fil conducteur sera toujours le même. Avant de demander quel mot appliquer à une personne, il faut comprendre ce qui lui arrive, dans quelles circonstances, depuis quand, avec quelles conséquences et à quel prix. Le diagnostic peut alors prendre sa place. Il devient une information importante parmi d'autres, au lieu de devenir la totalité du portrait.

L'expression « architectures mentales » sert ici de métaphore de travail : elle désigne un agencement mobile de capacités, de contraintes et d'appuis. Elle ne renvoie ni à une structure cérébrale directement observable ni à un type de cerveau fixe.

Chapitre 1.

Il n'existe pas un cerveau normal



Chapitre 1. Il n'existe pas un cerveau normal

À vingt-neuf ans, Nora se décrit comme « incapable de travailler normalement ». La formule est large. Elle dit pourtant quelque chose de son expérience. Dans un bureau silencieux, avec une tâche clairement découpée, elle avance vite. Dans un espace partagé, chaque conversation voisine capture son attention. Une demande imprévue l'oblige à reprendre mentalement le fil. Le soir, elle termine parfois ce qu'elle n'a pas achevé au travail et conclut que les autres possèdent un cerveau plus fiable que le sien.

Nora est fictive. Aucun diagnostic ne lui sera attribué. Son cas introduit une difficulté de vocabulaire. « Normal » peut désigner ce qui est fréquent, ce qui se situe dans une plage statistique, ce qui est attendu socialement ou ce qui est jugé souhaitable. Ces sens se recouvrent imparfaitement. Une caractéristique rare peut être compatible avec une vie satisfaisante. Une capacité située dans la moyenne peut devenir insuffisante lorsque les exigences d'une tâche augmentent brutalement. Une conduite jugée étrange dans un milieu peut paraître banale dans un autre.

Les mesures de capacités humaines décrivent des distributions et des profils. Elles permettent de comparer des résultats sans supposer qu'un individu unique représenterait toutes les performances attendues. Le titre de ce chapitre doit être entendu dans ce sens : il n'existe pas un portrait complet du fonctionnement auquel chacun devrait correspondre. Cette observation laisse entière la possibilité de reconnaître des troubles et des limitations.

Une moyenne reste indispensable. Sans groupe de référence, impossible de savoir si une performance se situe près de ce que l'on observe habituellement à un âge donné. Les tests cognitifs, les mesures scolaires et de nombreux examens médicaux utilisent ce principe. Le problème commence lorsque la moyenne

devient une personne imaginaire à laquelle chacun devrait ressembler dans tous les domaines. Les profils réels sont irréguliers. Une personne peut disposer d'un vocabulaire très développé et d'une mémoire de travail fragile, exceller dans le raisonnement abstrait et perdre ses moyens lorsque plusieurs consignes arrivent en même temps.

Les usages de la moyenne

Supposons qu'une activité demande à la fois de lire rapidement, de conserver plusieurs éléments en mémoire et de répondre devant un groupe. On peut mesurer chacune de ces capacités dans une population. La personne qui se situe près de la moyenne sur la première ne se trouvera pas nécessairement au même endroit sur les deux autres. Décrire la moyenne de chaque mesure permet des comparaisons. En faire le portrait d'un individu complet ajoute une supposition que les mesures ne contiennent pas.

Cette différence entre un repère et un modèle à reproduire devient importante dans les institutions. Un délai commun simplifie l'organisation d'un examen. Il peut aussi transformer la vitesse d'exécution en condition d'accès à une bonne note, même lorsque la connaissance évaluée ne dépend pas directement de cette vitesse. Il faudra alors examiner la place réelle du temps dans l'activité. Pour certaines tâches, agir vite est indispensable. Dans d'autres, la contrainte provient surtout du mode d'organisation retenu.

La norme sociale possède encore une autre fonction. Elle permet d'anticiper les conduites et de coordonner les échanges. Savoir à quel moment prendre la parole rend une conversation plus facile. Toutefois, une convention peut être si familière à ceux qui la partagent qu'ils cessent de la percevoir comme une convention. Ils attribuent alors à un manque d'intérêt ce qui pourrait relever d'une difficulté à reconnaître le moment attendu, d'une incertitude sur la règle ou d'un autre mode de participation. L'interprétation devra rester ouverte tant que la situation n'aura pas été examinée.

La distinction ne conduit pas à déclarer toute attente arbitraire. Traverser une rue suppose de tenir compte des

véhicules, indépendamment de la manière dont une société valorise la spontanéité ou la prudence. Les conséquences d'une difficulté peuvent être concrètes et graves. Une analyse des normes doit reconnaître la différence entre une préférence collective discutable et une exigence liée à la sécurité, puis rechercher comment rendre cette dernière accessible.

L'irrégularité d'un profil cognitif ne suffit pas à parler de trouble. Elle invite plutôt à repérer les différences qui comptent réellement dans la vie de la personne, les situations où elles deviennent visibles et leurs conséquences. Chez Nora, le bruit, les interruptions et la superposition des demandes semblent importants. Il resterait à établir l'ancienneté de cette sensibilité, sa présence dans plusieurs contextes, les stratégies déjà utilisées, l'effet du sommeil et les autres facteurs susceptibles d'expliquer une partie des difficultés.

La notion de neurodiversité prend son intérêt à cet endroit. Elle incite à considérer les variations neurologiques et cognitives comme faisant partie de la diversité humaine. Selon les auteurs et les mouvements qui l'emploient, elle porte aussi des propositions sur le handicap, la stigmatisation, les droits et l'organisation de la société. Ces propositions ne se confondent pas avec une découverte unique qui aurait démontré que toutes les différences sont bénignes. Le terme rassemble une famille d'approches, parfois proches, parfois discutées. [1]

Ce que le mot neurodiversité rassemble

Dans cet ouvrage, la neurodiversité désigne la diversité des fonctionnements à l'échelle humaine. Le mot « neurodivergent » sera utilisé lorsqu'il aide à comprendre les discours de personnes ou de groupes qui se reconnaissent dans un écart aux attentes dominantes. Son périmètre varie selon les usages. Il ne possède pas ici la fonction d'un diagnostic supplémentaire. Une personne peut employer ce terme pour raconter son expérience, tandis qu'un professionnel utilise une catégorie clinique afin de préciser une évaluation. Les deux interlocuteurs ne font pas nécessairement le même travail avec les mots. [1]

Cette pluralité impose une attention aux changements de registre. Constater des différences, défendre des droits et

proposer une théorie de l'esprit sont des démarches distinctes. Une argumentation peut passer de l'une à l'autre, à condition de rendre ce passage visible. L'existence de variations ne démontre pas, à elle seule, qu'une intervention particulière est efficace. Le souhait d'une société plus accueillante reste un choix collectif à discuter, même lorsqu'il s'appuie sur des connaissances bien établies.

Cette image de travail aide surtout à abandonner l'idée d'un classement unique. Une personne peut rencontrer un obstacle important dans une activité et disposer ailleurs de ressources solides. Il serait tout aussi trompeur de transformer chaque difficulté en talent caché. Dans notre exemple, Nora peut apprécier la profondeur d'un travail solitaire sans être exceptionnellement créative. La raison d'examiner son environnement est déjà suffisante : elle souhaite accomplir son travail dans des conditions tenables.

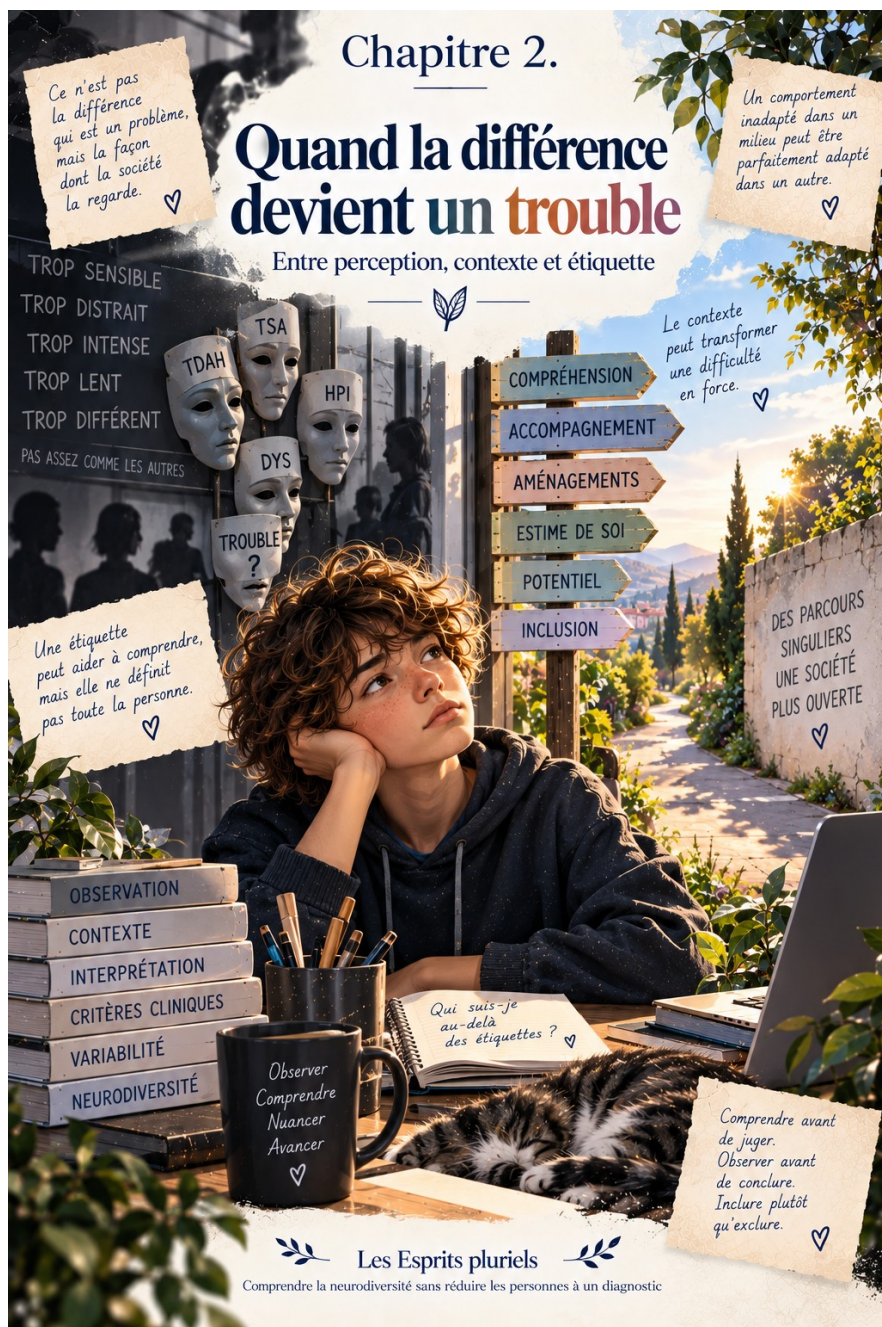
On peut également décrire une différence sans en faire le centre d'une identité. Nora possède une histoire, des relations, des habitudes et des projets dont son rapport au bruit n'épuise pas le sens. La précision du portrait protège cette pluralité. Elle évite qu'un détail frappant organise toutes les interprétations, comme si les autres aspects de sa vie devaient désormais en découler.

À force de valoriser la variation, on pourrait minimiser les limitations sévères. Lorsqu'une personne communique difficilement ses besoins, dépend d'une aide quotidienne ou subit une surcharge sensorielle intense, la priorité porte sur la reconnaissance précise de cette difficulté et sur les soutiens nécessaires. La diversité humaine comprend aussi des besoins de soutien importants.

La variabilité constitue le premier élément de notre cartographie. Au lieu de chercher immédiatement un type de cerveau, on relève les domaines dans lesquels une personne se distingue, les situations où l'écart devient visible et celles où il disparaît. Cette première carte ne fournit aucune conclusion clinique. Elle remplace l'image d'un cerveau normal unique par une description plus fidèle des différences entre personnes et à l'intérieur d'une même personne.

Pour commencer à comprendre Nora, on pourrait comparer deux journées qu'elle connaît déjà. Dans l'une, elle prépare un dossier avant l'arrivée des collègues. Dans l'autre, elle essaie de réaliser le même travail entre plusieurs sollicitations. Les différences observées donneraient des indications sur les conditions de l'activité. Elles resteraient compatibles avec plusieurs explications. Une journée plus facile ne mesure pas la nature profonde d'une personne, pas plus qu'une journée difficile ne résume ses capacités.

Cette prudence n'enlève rien à l'utilité de l'observation. Elle la rend plus précise. Nora pourrait découvrir que le problème concerne surtout la reprise après une interruption, ou que les échanges imprévus occupent une part du temps qui n'était comptée nulle part. Elle pourrait aussi constater que les difficultés débordent largement le bureau. Le travail commence lorsque le mot « normal » cesse de clore la description et devient une demande d'explication.



Chapitre 2. Quand la différence devient un trouble

Imaginez Malik, trente-quatre ans, chargé de coordonner plusieurs dossiers dans une petite entreprise. Lorsqu'il reçoit une demande unique, il la traite rapidement. Lorsque trois collègues le sollicitent presque au même moment, il commence une tâche, ouvre un second document, répond à un message, puis oublie ce qu'il voulait vérifier dans le premier. Son responsable lui propose d'utiliser une liste partagée et de regrouper les demandes non urgentes. Les oublis diminuent.

Malik est fictif. Cette amélioration ne dit encore rien sur un diagnostic. Elle établit seulement qu'un changement d'organisation modifie son fonctionnement dans une situation précise.

Décrire avant d'expliquer demande une discipline rarement spectaculaire. L'enquête commence par les faits disponibles : ce qui échoue ou coûte davantage, l'ancienneté et la fréquence, les milieux concernés, puis les conséquences sur les études, le travail, les relations, l'autonomie ou la santé. La parole de la personne compte, tout comme les observations de l'entourage lorsqu'elles sont pertinentes et les résultats d'une évaluation lorsqu'elle existe. Ces sources peuvent converger ou éclairer des aspects différents de la même situation.

Donner une forme à la difficulté

Une description change déjà la conversation. « Malik manque de rigueur » attribue une propriété générale. « Malik oublie surtout les demandes reçues pendant qu'il en traite une autre » situe un événement. La deuxième phrase reste à vérifier, mais elle permet de chercher des conditions comparables, d'interroger Malik et d'examiner une modification possible. Elle n'efface ni la responsabilité professionnelle ni les conséquences des oublis. Elle donne des prises pour agir.

L'observation d'un proche possède sa valeur et ses limites. Un collègue voit les retards, rarement les heures consacrées à rattraper le travail. Malik ressent sa fatigue, sans toujours remarquer les interruptions que les autres ont comptées. Un test peut explorer une capacité dans des conditions précises, différentes de celles du bureau. Lorsque ces sources divergent, le désaccord devient une information à comprendre. Il peut porter sur des moments, des tâches ou des critères de réussite qui ne sont pas les mêmes.

La portée du problème doit elle aussi être précisée. Un oubli isolé dans une semaine chargée et une désorganisation durable qui compromet plusieurs domaines de vie demandent des interprétations différentes. L'ancienneté, la fréquence et la gravité des conséquences ne sont pas interchangeables. Une conduite rare peut être dangereuse. Une gêne fréquente peut demeurer limitée. Le raisonnement clinique examine ces dimensions selon les critères propres au trouble envisagé, avec l'histoire de la personne et les autres explications possibles.

Le passage d'une difficulté à un trouble clinique ne repose pas sur une règle universelle. Chaque diagnostic possède ses exigences. Dans le TDAH, par exemple, les recommandations professionnelles insistent sur une évaluation clinique complète, l'histoire développementale, le retentissement fonctionnel, la présence des manifestations dans plusieurs contextes et l'examen d'autres explications possibles. Une ressemblance avec quelques symptômes lus sur une page internet reste très loin de ce travail. [4], [5]

Un professionnel peut ainsi chercher à savoir si la difficulté est ancienne, si elle s'accroît pendant une période particulière, si elle accompagne un autre problème de santé ou si plusieurs troubles coexistent. Ce travail ne revient pas à choisir le portrait internet qui ressemble le plus à Malik. Dans les recommandations françaises sur le TDAH de l'enfant et de l'adolescent, l'examen des diagnostics différentiels et des troubles associés fait partie de l'évaluation. [4] L'exemple est utile pour comprendre la démarche, sans appliquer automatiquement à un adulte une procédure pédiatrique.

Le diagnostic et la demande d'aide suivent parfois des temporalités différentes. Malik peut bénéficier d'une clarification des priorités pendant qu'une évaluation se prépare. Cette amélioration pratique n'anticipe pas la conclusion clinique. Elle répond à un obstacle identifié. De même, une évaluation qui ne retient pas le diagnostic envisagé laisse entière la nécessité de comprendre une difficulté persistante et de chercher une réponse adaptée.

Le retentissement mérite une attention particulière. Une difficulté peut devenir visible lorsque les exigences dépassent les ressources disponibles. Un enfant qui compensait jusque-là une lecture lente peut rencontrer davantage d'obstacles lorsque les textes s'allongent. Un adulte peut découvrir des difficultés d'organisation après une promotion qui multiplie les interruptions. Le phénomène peut sembler nouveau alors que certaines caractéristiques existaient auparavant sous une forme moins coûteuse.

Cette évolution conduit parfois à une confusion causale. Si un environnement plus exigeant révèle une difficulté, on peut être tenté d'affirmer que cet environnement a créé le trouble. Si un aménagement améliore la situation, on peut croire avoir démontré que l'origine était environnementale. Ces conclusions dépassent les observations. Une paire de lunettes améliore la vision sans nous renseigner, à elle seule, sur l'origine d'un trouble visuel. De la même manière, une modification de tâche peut réduire un retentissement sans expliquer l'ensemble du développement qui a conduit au problème.

La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l'Organisation mondiale de la santé fournit ici un cadre utile. Elle décrit le fonctionnement et le handicap en tenant compte du contexte, notamment des facteurs environnementaux. Cette perspective déplace l'attention vers les activités réellement réalisées et la participation à la vie quotidienne. Elle ne fixe toutefois aucun pourcentage universel de responsabilité entre l'individu et son milieu. [2]

L'activité et la participation

Le cadre de la CIF aide à déplacer le regard vers ce que la personne peut réaliser et vers les situations auxquelles elle participe. [2] Ces deux questions ne se superposent pas toujours. Quelqu'un peut posséder une compétence et l'utiliser rarement parce que l'accès à l'activité est trop difficile. Une personne peut aussi participer grâce à une aide importante. Décrire seulement la performance finale efface alors une partie des conditions qui l'ont rendue possible.

Imaginons qu'un trajet soit réalisable lorsqu'un proche le prépare, vérifie l'horaire et accompagne la correspondance. Le trajet accompli témoigne d'une possibilité réelle. Il ne prouve pas que l'accompagnement est devenu inutile. L'aide appartient au fonctionnement observé. La supprimer du récit conduit à surestimer l'autonomie, tandis que parler uniquement de dépendance ferait disparaître l'activité que la personne accomplit effectivement.

Cette distinction vaut aussi pour les institutions. Un service peut être théoriquement ouvert à tous et pratiquement difficile à utiliser. Il peut exiger plusieurs démarches dans un ordre implicite, changer d'interlocuteur à chaque étape ou demander de résumer oralement une histoire complexe. Le constat d'une difficulté d'accès ne suffit pas à diagnostiquer ceux qui la rencontrent. Il autorise déjà à examiner la procédure, son objectif et les exigences qu'elle ajoute.

Une explication environnementale devient insuffisante lorsqu'elle prétend tout couvrir. Une personne peut éprouver des difficultés dans des activités choisies, au sein de relations soutenant et dans un milieu qui s'efforce de s'adapter. Elle peut souhaiter apprendre un geste et avoir durablement besoin d'aide. Prendre au sérieux cette expérience demande de conserver plusieurs possibilités d'intervention, parmi lesquelles les soins, les apprentissages accompagnés et le soutien humain. La reconnaissance de la diversité doit laisser cette demande pleinement audible.

Revenons à Malik. La liste partagée diminue ses oublis, mais peut-être continue-t-il à consacrer une énergie considérable à maintenir son attention. Peut-être les difficultés persistent-elles à

la maison. Peut-être disparaissent-elles complètement en dehors d'une période de surcharge professionnelle. Chacune de ces possibilités modifie l'interprétation. L'efficacité d'un aménagement devient une information supplémentaire, pas un verdict.

Supposons maintenant que Malik réussisse mieux au bureau mais continue à perdre le fil de démarches personnelles importantes. L'amélioration professionnelle reste précieuse. Elle montre aussi que la liste partagée ne répond pas à tous les contextes. Le prochain problème concerne une démarche reçue par courrier, composée de plusieurs étapes et reprise après quelques jours. Le travail porte alors sur l'organisation de cette reprise. On conserve ce qui fonctionne tout en reconnaissant la portée limitée du changement.

À l'inverse, si les difficultés disparaissent après une période de surcharge et ne trouvent aucun prolongement dans son histoire, cette évolution devra compter dans l'évaluation. La méthode doit pouvoir accueillir cette éventualité. Une hypothèse que toute amélioration confirme et que toute persistance confirme également devient impossible à mettre à l'épreuve. Le sérieux du raisonnement tient en partie à la possibilité de réviser ce que l'on croyait comprendre.

Chez Malik, l'ancienneté, les contextes, les conséquences et les aides déjà présentes deviennent des informations distinctes. Une difficulté prend un sens différent selon qu'elle apparaît depuis quelques semaines ou traverse l'histoire développementale, selon qu'elle concerne une seule tâche ou plusieurs domaines, selon qu'elle provoque une gêne limitée ou compromet l'autonomie.

Chapitre 3.

TDAH : une même étiquette, plusieurs fonctionnements



Les Esprits pluriels

Comprendre la neurodiversité
sans réduire les personnes à un diagnostic

Chapitre 3. TDAH : une même étiquette, plusieurs fonctionnements

Élise remet souvent ses tâches administratives au dernier moment. Elle peut rester deux heures absorbée par un problème technique qui l'intéresse, puis oublier un rendez-vous noté le matin même. Thomas, lui, interrompt fréquemment ses collègues, bouge pendant les réunions et prend des décisions rapides qu'il regrette ensuite. Les deux personnages sont fictifs. Les comportements décrits peuvent évoquer le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), mais leur contraste rappelle déjà qu'une catégorie diagnostique ne produit pas un portrait unique.

Le TDAH appartient aux troubles du neurodéveloppement. Les descriptions cliniques s'intéressent à des manifestations d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité qui s'inscrivent dans le temps et entraînent un retentissement significatif. L'évaluation examine l'histoire de la personne, plusieurs domaines de vie et les diagnostics différentiels. Elle cherche aussi les conditions associées, fréquentes dans les situations cliniques. [6]

Le mot « attention » prête à confusion. Dans la vie courante, il évoque une quantité simple que l'on posséderait en plus ou en moins. L'expérience réelle est plus variable. Une personne peut maintenir longtemps son engagement dans une tâche motivante et perdre rapidement le fil d'une activité monotone. Elle peut se concentrer dans le calme et être débordée par les interruptions. Elle peut comprendre parfaitement une consigne et échouer à organiser les étapes nécessaires pour l'exécuter au moment prévu.

Soutenir une action jusqu'à son terme

Pour comprendre la tâche administrative d'Élise, il faut la suivre au-delà de l'intention. Elle doit retrouver les documents, décider par où commencer, conserver les étapes en tête, remarquer une pièce manquante et reprendre le dossier après l'avoir cherchée. L'échec final peut provenir d'un endroit précis de cette succession. La formule « elle ne s'y met pas » rassemble plusieurs opérations sous un jugement unique et rend plus difficile l'identification d'un appui utile.

Les fonctions exécutives désignent un ensemble de processus impliqués dans la conduite d'une action orientée vers un but. Dans une explication accessible, on peut parler de maintenir une information utile, retenir une réponse trop rapide, changer de stratégie ou organiser des étapes. Ces notions aident à décrire certains obstacles. Elles ne fournissent pas une signature individuelle du TDAH. Le bilan d'une personne demande davantage que la présence d'une difficulté d'organisation, et les personnes diagnostiquées ne présentent pas toutes le même profil à chaque épreuve. [4]

La motivation doit également être décrite avec soin. Une tâche peut devenir plus facile lorsqu'elle offre un retour rapide, une échéance proche ou un intérêt fort. On peut examiner ces conditions sans conclure que la personne aurait pu choisir la même mobilisation partout. L'intérêt ne s'ajoute pas à une activité comme un interrupteur volontaire. Pour autant, il ne garantit pas sa réussite : une activité passionnante peut aussi demander des étapes ingrates et une gestion du temps qui restent difficiles.

L'expression « hyperfocus » circule pour désigner une absorption intense. Elle décrit une expérience possible, mais ne constitue pas à elle seule un critère diagnostique du TDAH. Dans notre exemple, Élise peut progresser sur son problème technique tout en ayant du mal à s'arrêter à l'heure prévue. La valeur de l'épisode dépend alors de ce qu'il permet et de ce qu'il empêche. Une concentration prolongée peut servir une activité choisie ou empiéter sur d'autres obligations, parfois au cours de la même journée.

Ces variations ne contredisent pas le diagnostic. Elles montrent pourquoi l'observation d'une performance isolée renseigne peu. Dire d'un étudiant qu'il « peut se concentrer quand il veut » transforme une fluctuation en jugement moral. Dire qu'il « ne peut jamais se concentrer » simplifie dans l'autre sens. Une description plus utile repère les conditions qui stabilisent ou fragilisent la performance.

Les recommandations de NICE accordent une place explicite aux modifications environnementales dans la prise en charge du TDAH. Elles citent notamment la réduction des distractions, l'adaptation de l'organisation du travail, le renforcement des consignes verbales par l'écrit et des périodes de concentration plus courtes avec des pauses. Elles précisent également que les symptômes peuvent continuer à entraîner un retentissement significatif malgré ces modifications. Le milieu infléchit la difficulté sans l'effacer nécessairement. [5]

Les descriptions réductrices figent parfois le TDAH en déficience identique dans toutes les situations. D'autres l'expliquent presque entièrement par des institutions trop rigides. Les données cliniques et les expériences individuelles décrivent un paysage plus complexe, où l'organisation, les traitements, les stratégies personnelles et la persistance de certaines difficultés se combinent différemment selon les personnes.

Les aides et les soins dans une même vie

Un rappel rend un rendez-vous visible au bon moment. Il faut encore pouvoir interrompre l'activité en cours, préparer le déplacement et partir. Multiplier les alertes peut finir par les rendre indistinctes. Pour Élise, la bonne question serait de savoir à quelle étape elle perd la possibilité d'agir. Le support utile peut concerner la préparation de la veille, l'estimation du trajet ou la place du rendez-vous dans la journée. Le succès d'une application chez un proche ne résout pas cette analyse.

Thomas rencontre un problème différent. Il peut comprendre qu'il interrompt et souhaiter laisser davantage de place aux autres. Une règle de réunion explicite, un ordre de passage ou un moyen de noter sa question peuvent être essayés avec son accord. L'objectif serait de permettre une participation plus satisfaisante

pour lui et pour le groupe. La description de sa difficulté ne l'exonère pas de toute responsabilité. Elle permet de définir une responsabilité praticable, assortie de moyens et d'un retour sur les effets.

Les traitements du TDAH peuvent associer médicaments, interventions psychologiques et soutiens adaptés. Le choix dépend de l'âge, de la situation clinique, des bénéfices attendus et des effets indésirables possibles. Le NIMH présente cette pluralité de moyens chez l'enfant et l'adulte. [6] Dans un livre sur la neurodiversité, cette place des soins mérite d'être explicite. Une personne peut vouloir réduire une souffrance ou retrouver une capacité d'action sans renoncer à la manière dont elle comprend son identité.

Le livre n'a pas à déterminer quelle combinaison convient à Élise ou Thomas. Ces personnages ne possèdent aucun dossier clinique. Leur utilité est de montrer pourquoi l'évaluation d'un résultat doit dépasser la réussite ponctuelle. Une stratégie qui aide à tenir une semaine en réduisant fortement le sommeil soulève un autre problème que celle qui stabilise durablement l'organisation. Le jugement sur l'aide doit inclure sa faisabilité, son coût et les priorités de la personne.

La question des forces demande la même prudence. Des personnes avec TDAH décrivent parfois une grande spontanéité, une énergie élevée, une pensée associative ou une capacité à s'engager fortement dans certains intérêts. Ces qualités peuvent compter dans une trajectoire. Elles ne font pas partie d'un lot obligatoire livré avec le diagnostic. Associer systématiquement un trouble à un « superpouvoir » risque de remplacer un stéréotype négatif par un stéréotype valorisant tout aussi réducteur.

Grandir avec des exigences qui changent

L'enfant bénéficie souvent d'un cadre dont les adultes accomplissent une partie du travail invisible. Un parent prépare le sac, un enseignant rappelle l'étape suivante, un horaire stable rend plusieurs décisions inutiles. À mesure que l'autonomie attendue augmente, ces appuis changent. La difficulté peut devenir plus visible au passage dans un établissement où il faut gérer plusieurs professeurs, puis lors de l'entrée dans les études

supérieures ou la vie professionnelle. Le moment où elle est reconnue ne coïncide pas nécessairement avec son commencement. [7]

Cette histoire doit être reconstruite avec prudence. Les souvenirs se réorganisent à la lumière du présent. Un bulletin ancien peut signaler une difficulté, ou ne rien dire d'un effort considérable resté discret. Les informations disponibles ne sont pas toujours complètes. Leur recherche a du sens lorsqu'elle aide à comprendre le développement et les besoins actuels. Elle perd ce sens si elle devient une enquête destinée à faire entrer chaque épisode dans une explication unique.

Pour les proches, une compréhension plus précise peut modifier la manière de demander de l'aide. Au lieu d'ajouter un reproche global à chaque oubli, ils peuvent convenir d'un mode de transmission et de priorités réalistes. Cette coopération ne doit pas reposer sur la disponibilité illimitée d'une seule personne. Le soutien a lui aussi un coût, qui doit pouvoir être discuté sans transformer les difficultés de l'un en culpabilité de l'autre.

Pour Élise et Thomas, une description utile relie la régulation de l'attention et de l'action aux tâches effectivement rencontrées. Les rappels, les routines et l'aide d'un tiers font partie des conditions de réussite. Il reste à savoir si ces appuis peuvent être maintenus sans surveillance permanente ni coût excessif.



Chapitre 4. Autisme : parler d'un spectre sans effacer les personnes

Sofia prépare chaque déplacement avec minutie. Elle repère l'itinéraire, vérifie les horaires et préfère savoir qui sera présent. Les changements de dernière minute lui coûtent beaucoup. Idriss utilise peu la parole, dispose d'une tablette pour certains échanges et dépend d'un proche pour plusieurs activités quotidiennes. Ces deux personnages fictifs sont imaginés ici avec un diagnostic d'autisme. Les quelques conduites décrites ne permettraient pas, à elles seules, de l'établir dans une situation réelle.

L'Organisation mondiale de la santé présente l'autisme comme un groupe divers d'affections liées au développement du cerveau. Les descriptions cliniques portent notamment sur la communication et les interactions sociales, ainsi que sur des comportements ou intérêts répétitifs, restreints ou atypiques, avec des particularités sensorielles possibles. Les capacités intellectuelles, le langage, l'autonomie et les besoins de soutien varient largement. [8]

Cette hétérogénéité a une conséquence éditoriale. Parler de l'autisme à partir des seules personnes capables d'expliquer finement leur expérience en entretien produit un échantillon commode et incomplet. Les personnes qui ont besoin d'une aide importante, celles qui utilisent peu le langage oral et celles dont les proches participent davantage à la communication doivent rester présentes dans le récit. Leur expérience ne peut pas être reconstruite à partir d'un modèle unique de l'adulte autonome.

Le spectre comporte plusieurs dimensions

Le mot « spectre » se prête à une représentation trompeuse lorsque l'on imagine une ligne allant de « peu autiste » à « très autiste ». Un portrait individuel demande plusieurs descriptions. La parole orale, la compréhension d'une situation, l'autonomie domestique, la tolérance aux changements et la possibilité de

communiquer un besoin ne se déplacent pas nécessairement ensemble. Une aptitude aisément visible peut coexister avec un besoin d'aide que l'entourage perçoit moins bien. [8]

Sofia sait préparer un itinéraire. Cette capacité ne dit pas ce qui se passe lorsqu'un train est supprimé et qu'une annonce sonore donne rapidement trois possibilités de remplacement. Idriss peut avoir besoin d'assistance pour ce trajet tout en exprimant une préférence nette pour la destination. Un jugement global sur leur niveau de fonctionnement ferait disparaître ces différences. Pour préparer une sortie, il est plus utile de connaître les étapes possibles, les informations accessibles et l'aide nécessaire à chacune.

Le niveau de langage oral renseigne imparfaitement sur la compréhension. Une personne qui parle peu peut comprendre certains échanges avec précision et rencontrer d'autres obstacles de compréhension. Les moyens d'expression et de compréhension demandent une évaluation propre avec des personnes compétentes. Dans la vie quotidienne, l'interlocuteur peut déjà laisser un délai, réduire l'ambiguïté et prêter attention aux moyens effectivement utilisés. L'objectif consiste à rendre l'échange possible tout en attribuant à la personne uniquement ce qu'elle a pu exprimer. [9]

L'interaction elle-même peut être étudiée. En 2020, Catherine Crompton et ses collègues ont comparé la transmission d'un récit auprès de 72 adultes répartis en chaînes de transmission. Les chaînes mixtes, composées de personnes autistes et non autistes, perdaient davantage d'informations, sans différence significative entre les deux types de chaînes homogènes. [10] Une réplication et extension publiée en 2025, auprès de 311 participants, n'a pas retrouvé de différence de transmission entre chaînes homogènes et mixtes. [25]

Une méta-analyse publiée en 2025 décrit aussi des résultats différents selon les dimensions et les instruments utilisés pour mesurer l'empathie dans l'autisme. Comprendre une intention, éprouver une réponse émotionnelle et manifester cette réponse relèvent de mesures distinctes. [11]

PORTÉE DES ÉTUDES CITÉES

L'étude de 2020 porte sur la transmission d'un récit entre adultes capables de participer à cette tâche, et sa réplication de 2025 n'a pas retrouvé le résultat principal sur les chaînes mixtes. La synthèse consacrée à l'empathie montre de son côté combien les conclusions dépendent des mesures retenues. Ces travaux ne justifient ni une règle générale sur toutes les interactions sociales ni une déduction sur l'empathie d'une personne particulière. [10] [11] [25]

Le rôle du contexte devient particulièrement visible dans les environnements sensoriels. Une lumière, un bruit, une foule ou une transition imprévue peuvent accroître la charge d'une activité. Modifier ces conditions peut rendre une participation possible. Une meilleure accessibilité réduit certaines charges, tandis que des difficultés peuvent persister dans des environnements très soutenant. Certaines personnes ont besoin d'aide durable pour communiquer, se déplacer, prendre soin d'elles-mêmes ou gérer des situations dangereuses.

Comprendre une situation devenue intenable

Reprenons Idriss. Il refuse soudain d'entrer dans une pièce qu'il fréquentait jusque-là. Une interprétation rapide pourrait évoquer une rigidité. D'autres éléments méritent d'être recherchés : un bruit nouveau, une interaction pénible, un changement de repères ou une douleur. Les recommandations de NICE pour l'autisme de l'adulte invitent notamment à rechercher des problèmes physiques lorsque les conduites changent et que la personne peut avoir du mal à communiquer sa souffrance. [9] Le diagnostic ne doit pas rendre l'entourage moins attentif à ce qui lui arrive.

L'expression « comportement difficile » décrit d'abord une difficulté pour quelqu'un. Elle laisse encore à comprendre ce qui précède la conduite, ses conséquences et la manière dont la personne peut exprimer un refus ou demander une pause. Cette analyse doit prendre la sécurité au sérieux sans réduire l'objectif à la disparition du signe visible. Une pièce redevenue silencieuse

ne constitue pas une réussite si la personne a simplement cessé de pouvoir manifester son inconfort.

Les routines demandent la même attention. Elles peuvent rendre une journée prévisible, diminuer le nombre de décisions et soutenir une activité appréciée. Elles peuvent aussi devenir une contrainte lorsque chaque variation déclenche une difficulté importante. Le choix d'une intervention doit partir de la situation et du besoin concerné. Dans notre exemple, préparer une solution de remplacement avec Sofia pourrait soutenir un projet de voyage qu'elle désire. Lui imposer des changements sans but partagé serait une autre démarche.

Pour Sofia et Idriss, l'environnement relationnel et sensoriel demande une description précise. Les moyens de communication, les transitions et les besoins d'assistance ne peuvent pas être déduits d'un niveau global. Une conduite visible, comme quitter une pièce, doit être replacée dans ce qui l'a précédée et dans la possibilité d'exprimer un besoin.

Les besoins durables ont leur place

L'aide quotidienne comprend parfois une série de gestes qui ne disparaissent pas avec une meilleure information du public. Préparer un repas, organiser une prise de rendez-vous, prévenir un danger ou accompagner une communication peuvent demander une présence régulière. La reconnaissance de ces besoins oblige à parler de temps disponible, de continuité des services et de soutien aux proches. L'inclusion se joue aussi dans cette organisation ordinaire, loin des portraits de talents exceptionnels.

La personne doit rester présente dans les décisions qui la concernent, y compris lorsque son expression est difficile à interpréter. Il faut rechercher ses préférences avec les moyens accessibles, accepter une part d'incertitude et distinguer son intérêt de la commodité de l'organisation. Les proches apportent des connaissances souvent précieuses sur ses habitudes. Leur parole ne devient pas pour autant une traduction transparente de son expérience intérieure. Cette limite appelle une coopération attentive plutôt qu'une prétention à savoir à sa place.

Il est possible de défendre à la fois une meilleure accessibilité et des soutiens spécialisés. Leur articulation dépend des besoins concrets. Sofia et Idriss ne représentent pas deux degrés d'une même réussite sociale attendue. Chacun doit pouvoir disposer d'un projet qui tienne compte de ses possibilités, de ses préférences et des difficultés qui persistent. Le travail de description consiste à rendre ce projet discutable et ajustable, avec ceux qui peuvent aider à le réaliser.



Chapitre 5. Troubles dys : lorsque l'apprentissage reste coûteux

Dans cette nouvelle situation fictive, Léo, neuf ans, comprend rapidement les histoires qu'on lui raconte. Lorsqu'il doit les lire seul, il avance lentement, hésite sur certains mots et termine épuisé. Sa sœur, au même âge, lisait sans difficulté mais avait besoin de beaucoup plus de temps pour certains apprentissages arithmétiques. Le mot « dys » rapproche plusieurs difficultés sans les transformer en un seul profil. La dyslexie concerne notamment la lecture et l'orthographe, sans définir l'intelligence globale. [23]

Les classifications distinguent les troubles développementaux des apprentissages selon les compétences concernées, notamment la lecture, l'expression écrite et les mathématiques. Leur identification demande d'examiner le caractère durable et significatif des difficultés, leurs conséquences et les autres explications possibles. Les conditions d'enseignement, la langue et les éventuelles difficultés sensorielles ou générales doivent être prises en compte. [3]

Cette définition rappelle que l'apprentissage se situe à la rencontre d'une personne et d'un enseignement. Lire n'est pas une capacité qui apparaît hors contexte. Elle se construit avec l'exposition à l'écrit, la langue, les méthodes pédagogiques et l'entraînement. Reconnaître l'influence de ces facteurs ne revient pas à dissoudre le trouble dans l'école. L'évaluation cherche précisément à comprendre pourquoi certaines difficultés persistent au-delà de ce que l'on attendrait compte tenu des occasions d'apprentissage. [3]

Plusieurs apprentissages sous un mot commode

Le langage oral mérite d'abord d'être distingué de la lecture. Le trouble développemental du langage concerne des difficultés durables dans l'apprentissage, la compréhension ou l'usage du langage. Une consigne peut être mal suivie parce que sa

formulation n'a pas été comprise. La fiche du NIDCD souligne que ces difficultés peuvent être prises à tort pour un problème de comportement et que leur impact peut se prolonger à l'âge adulte. [12] Ce déplacement de l'interprétation change la réponse possible : répéter une injonction plus fermement n'éclaire pas les mots qui restent obscurs.

Dans une autre scène fictive, une enseignante demande à Lina de souligner les éléments qui justifient sa réponse, après avoir éliminé ceux qui se contredisent. Lina connaît une partie du sujet, mais ne parvient pas à reconstruire les étapes de la consigne. On pourrait vérifier séparément ce qu'elle comprend du contenu et de la formulation. Cette séparation évite déjà d'attribuer tout l'échec à un manque d'étude.

La coordination motrice constitue un autre domaine. Le trouble développemental de la coordination, souvent appelé dyspraxie dans les usages courants, peut affecter des activités comme écrire, s'habiller ou manipuler des objets. Il peut continuer à avoir des conséquences à l'âge adulte. [13] Un élève peut ainsi connaître sa réponse et peiner à la rendre lisible dans le temps disponible. La difficulté d'écriture doit alors être examinée pour elle-même, avec les autres composantes de la tâche.

En mathématiques, il faut également distinguer ce qui est demandé. Comprendre une quantité, retrouver rapidement un résultat, poser une opération et interpréter un énoncé font intervenir des exigences différentes. Une personne peut rencontrer un obstacle dans une partie de cet ensemble et disposer de meilleures ressources dans une autre. Le terme « dyscalculie » ne dispense pas de ce travail de description. Il ne permet pas de déduire que tout raisonnement mathématique serait hors de portée.

Le retentissement change avec l'âge. Un enfant peut consacrer une énergie considérable au décodage et disposer de peu de ressources pour comprendre le texte. Plus tard, des outils numériques, un choix d'études compatible avec ses forces ou une meilleure automatisation peuvent réduire certains obstacles. D'autres difficultés demeurent, notamment lorsque la vitesse de

lecture, l'orthographe ou le calcul mental restent fortement sollicités.

La difficulté la plus visible peut enfin masquer la compétence que l'on cherche à comprendre. Léo échoue à une consigne écrite et la formule « difficulté de lecture » paraît immédiate. Pour l'analyse, elle doit être ouverte en précisant la compétence concernée, la manière dont elle a été évaluée et les autres fonctions sollicitées par la tâche.

Le temps libéré pour comprendre

Revenons à Léo. Si une grande partie de son effort est consacrée à identifier les mots, l'activité de lecture ne ressemble pas à celle d'un enfant pour qui cette étape est devenue plus aisée. On peut l'imaginer terminant une phrase sans avoir conservé le début suffisamment clairement pour en discuter. L'exemple distingue trois opérations que le résultat final confond souvent : prononcer les mots, comprendre un passage et pouvoir travailler longtemps sur un texte.

Une lecture à voix haute par un adulte peut permettre à Léo de discuter le contenu. Ce résultat indiquerait que certaines connaissances deviennent accessibles dans d'autres conditions. Il ne réglerait pas la difficulté de lecture elle-même. Selon l'objectif, on peut travailler une compétence précise ou utiliser une aide pour accéder à un autre apprentissage. La distinction évite que chaque cours d'histoire, de sciences ou de géographie devienne involontairement une nouvelle épreuve de décodage.

Les deux démarches peuvent coexister. L'apprentissage ciblé développe une capacité, tandis que la compensation rend une activité possible malgré une difficulté persistante. Leur place respective dépend du projet, des possibilités et du moment. L'usage d'une aide peut accompagner la poursuite d'un apprentissage, qui ne doit pas pour autant reporter indéfiniment l'accès aux autres connaissances.

La qualité de l'enseignement et les occasions d'apprendre doivent être prises en compte. Un enfant qui a peu fréquenté l'école ou qui découvre sa langue d'enseignement peut rencontrer des difficultés dont l'interprétation demande un autre travail. La recherche d'un trouble suppose d'examiner ce que l'enfant a eu

la possibilité d'apprendre. Reconnaître cette condition protège d'une médicalisation trop rapide et d'un reproche scolaire adressé à quelqu'un dont la difficulté demeure malgré un enseignement adapté. [3]

Les trajectoires individuelles sont également hétérogènes. Une personne avec un trouble de la lecture peut avoir une compréhension orale riche, une autre présenter aussi des difficultés langagières. Certaines compensent grâce au contexte, à la mémoire ou à des stratégies développées au fil des années. Cette réussite visible peut masquer le temps consacré à vérifier, relire ou contourner une difficulté.

Accorder systématiquement plus de temps à tous les élèves portant la même étiquette paraît simple, mais cette règle risque de manquer l'obstacle réel. Chez certains, le temps supplémentaire réduit la pression et rend la compétence mieux observable. Chez d'autres, le problème principal se situe ailleurs, par exemple dans la compréhension de la consigne ou l'organisation des étapes. L'aménagement gagne à être relié à ce qu'il cherche concrètement à modifier.

Le choix d'un outil exige ensuite un apprentissage propre. Une synthèse vocale peut rendre un document audible, mais la personne doit pouvoir s'y repérer, régler le débit et retrouver une information. Un clavier peut alléger certains gestes et ajouter d'autres exigences. La présence du matériel ne suffit pas à décrire l'accessibilité. Il faut regarder l'usage réel, la formation disponible et la manière dont le document a été préparé.

L'entourage peut aussi confondre l'aide reçue et le travail évité. Si Léo écoute un texte pour préparer une discussion de sciences, il accomplit une activité dont l'objectif porte sur le contenu. Si l'exercice évalue précisément sa lecture autonome, la place de l'aide doit être pensée autrement. Le désaccord devient plus intelligible lorsque l'objectif est formulé. Dire seulement que l'aide facilite les choses ne permet pas de déterminer si elle fausse l'évaluation ou la rend plus fidèle.

Les difficultés au-delà de la scolarité

Les exigences liées à l'écrit et au calcul ne s'arrêtent pas à la sortie de l'école. Comparer une offre, suivre une procédure,

remplir un formulaire ou vérifier une facture mobilise ces compétences dans des situations parfois urgentes. Une personne peut avoir construit des méthodes efficaces et rencontrer de nouveaux obstacles lorsqu'une procédure change. Son expérience acquise demeure une ressource, même lorsqu'elle ne suffit plus dans le nouveau cadre.

Une adulte prépare ses rendez-vous à partir de messages qu'elle écoute sur son téléphone. Un service remplace ensuite les confirmations simples par un document numérisé difficile à lire avec son outil. La compétence n'a pas disparu du jour au lendemain. Une condition d'accès s'est modifiée. La recherche d'une réponse peut porter sur le format du document avant de demander à la personne un nouvel effort de compensation.

La honte peut rendre ces situations difficiles à raconter. On peut comprendre qu'une personne préfère éviter un formulaire plutôt que révéler une difficulté ancienne devant un inconnu. Il serait néanmoins abusif d'en faire l'expérience de toutes les personnes présentant un trouble dys. Certaines parlent facilement de leurs besoins, d'autres ont trouvé des contextes où ils ne posent plus le même problème. Un livre attentif doit laisser exister cette diversité de rapports à la difficulté.

Cette étape de la cartographie distingue la compétence ciblée de la tâche globale. Face à un échec, l'analyse décompose les composantes mobilisées : décodage, orthographe, mémorisation d'une procédure, compréhension de la consigne, planification de la réponse, vitesse d'écriture ou gestion du temps. Cette décomposition évite de transformer un résultat scolaire en jugement global sur l'intelligence.

La description gagnera enfin à séparer le résultat, le temps et les moyens. Deux productions correctes peuvent correspondre à des efforts très différents. Une activité plus lente peut demeurer satisfaisante lorsqu'aucune urgence ne s'y attache. Le même décalage peut devenir pénalisant dans un cadre où les délais sont serrés. L'évaluation de la situation demande alors de regarder l'importance de la vitesse pour l'objectif poursuivi et les marges réellement disponibles.

Pour Léo, comprendre son fonctionnement pourrait commencer par une phrase précise : il discute volontiers un récit

entendu, mais une lecture autonome longue lui demande un effort qui réduit sa disponibilité pour la suite. Cette phrase reste ouverte à la vérification et au changement. Elle dit davantage que « mauvais lecteur » sur les conditions à aménager, tout en laissant au travail clinique la responsabilité de préciser la nature de ses difficultés.

Chapitre 6.

Haut potentiel, hypersensibilité et zones grises



Chapitre 6. Haut potentiel, hypersensibilité et zones grises

Camille a obtenu un score très élevé à une évaluation intellectuelle. Depuis, plusieurs difficultés de sa vie ont été relues à travers cette information. Son ennui scolaire, son anxiété, sa sensibilité au bruit, ses relations parfois compliquées et sa fatigue seraient autant de conséquences d'un « haut potentiel ». Ce récit est fictif, mais sa logique est fréquente : une donnée réelle devient une explication générale.

Le haut potentiel intellectuel se rattache à la mesure psychométrique des aptitudes cognitives. Les seuils utilisés sont des conventions fondées sur une distribution statistique. Ils renseignent sur un niveau de performance sans définir une personnalité, une trajectoire émotionnelle ou une manière unique de penser. Les revues consacrées aux enfants intellectuellement doués décrivent d'ailleurs une forte hétérogénéité des profils. Certaines difficultés socio-émotionnelles apparaissent dans une partie des études, tandis que d'autres travaux ne trouvent pas de différence ou mettent en évidence des forces dans certains domaines. [14]

Un résultat de test et l'histoire qu'on lui associe

Un score prend son sens dans un instrument, un groupe de référence et des conditions de passation. Il résume des performances selon une méthode. Le commentaire professionnel peut aussi examiner la manière dont les résultats se répartissent entre les épreuves. Interpréter ce score comme une identité complète ajoute à la mesure des propositions qu'elle n'a pas été conçue pour établir. La vie émotionnelle, les relations ou les choix d'une personne demandent leurs propres informations.

Cette distinction devient particulièrement utile lorsque l'évaluation intervient après une période difficile. Camille cherchait une explication à un parcours qui lui semblait incohérent. Un résultat élevé lui apporte une information

nouvelle. Il peut modifier la manière dont elle comprend certains épisodes, sans établir à lui seul pourquoi elle souffre aujourd'hui. Le besoin de cohérence est compréhensible. Il peut aussi inciter à considérer comme démontré un lien qui reste à examiner.

La sélection des personnes observées influe sur les récits disponibles. Un professionnel qui rencontre des personnes en difficulté voit nécessairement une partie particulière de la population. Un groupe de soutien réunit ceux qui ont une raison de chercher du soutien. Leurs expériences méritent d'être entendues. Elles ne permettent pas de décrire directement tous les individus partageant un score élevé. Cette question d'échantillon compte chaque fois qu'une expérience clinique devient une affirmation générale.

La revue de Tasca et de ses collègues ne permet pas de conclure de façon univoque sur le lien entre haut niveau intellectuel et difficultés socioémotionnelles. Les populations, les informateurs et les instruments diffèrent entre les études. [14] Pour le lecteur, cette hétérogénéité signifie qu'il faut renoncer au portrait obligatoire de la personne brillante et nécessairement tourmentée. Elle n'autorise pas à ignorer la souffrance d'une personne donnée.

Cette prudence importe parce que le haut potentiel attire facilement des récits totalisants. Une personne peut se reconnaître dans l'intensité intellectuelle, la rapidité de raisonnement ou le décalage avec certaines activités scolaires. Elle peut aussi présenter un trouble anxieux, un TDAH, un trouble d'apprentissage ou aucun trouble. Le score intellectuel renseigne sur des performances obtenues dans des conditions précises. Il ne fournit pas une explication automatique à chaque souffrance.

Dans le langage courant, l'hypersensibilité peut désigner une réactivité émotionnelle, une sensibilité sensorielle ou une vulnérabilité au stress. Ces usages ne se recouvrent pas exactement. La recherche sur la sensibilité au traitement des stimulations, souvent appelée *sensory processing sensitivity*, étudie un trait psychologique avec des outils et des modèles spécifiques. Ce programme de recherche ne suffit pas à établir une catégorie clinique unique appelée « hypersensible ». [15]

Décrire ce que signifie être sensible

Lorsque Camille se dit hypersensible, le mot peut renvoyer à un bruit envahissant, à une émotion qui persiste après un échange ou à une attention soutenue aux réactions des autres. Ces expériences peuvent coexister. Leur regroupement sous une même étiquette ne démontre pas une cause commune. Une description plus fine aide à déterminer ce qui appelle une aide, une exploration clinique ou un ajustement du contexte.

La sensibilité au traitement des stimulations étudiée en psychologie constitue un champ défini par ses modèles et ses instruments. La synthèse de Greven et de ses collègues propose notamment une explication théorique liée au traitement prédictif de l'information, appuyée indirectement par certaines observations. Une proposition de mécanisme reste à distinguer d'une démonstration complète. [15] Il serait trompeur de la transformer en examen permettant de lire le fonctionnement cérébral d'une personne qui se reconnaît dans le terme « hypersensible ».

Le vocabulaire quotidien conserve néanmoins une utilité. Camille peut trouver dans ce mot une manière de demander que l'on baisse le volume ou que l'on respecte un temps de repos. On peut entendre cette demande sans exiger qu'une catégorie clinique la précède. Si sa difficulté est importante ou nouvelle, l'enquête devra rester plus large. Un mot qui aide à parler ne doit pas empêcher de chercher ce qui mérite d'être compris autrement.

Le « haut potentiel émotionnel », souvent abrégé HPE, demande une vigilance supplémentaire. Les recherches sur les émotions, la personnalité et l'empathie constituent des champs distincts. Leur rapprochement sous une formule valorisante ne démontre pas l'existence d'un profil unifié qui expliquerait les difficultés d'une personne.

Son adoption comme explication suppose de savoir ce que le concept mesure, comment cette mesure a été obtenue, avec quels groupes elle a été étudiée et ce qu'elle permet réellement de prédire. Une ressemblance entre une description personnelle et un modèle théorique peut ouvrir une piste de réflexion. Elle ne

suffit pas à établir que le modèle explique l'ensemble de cette personne.

Dans ce livre, le « HPE » désigne un niveau de performance psychométrique et non une catégorie diagnostique du neurodéveloppement. Les recherches sur l'intelligence émotionnelle ou l'empathie ne valident pas par simple proximité une catégorie populaire supplémentaire. Pour Camille, cette distinction protège la possibilité d'une évaluation de ses difficultés réelles. Elle évite qu'un récit séduisant absorbe à l'avance toute autre explication.

Ce que l'étiquette laisse ouvert

Une personne peut disposer de fortes capacités dans certaines tâches intellectuelles et avoir besoin d'aide dans d'autres domaines. La présence d'une ressource ne neutralise pas automatiquement un obstacle. Dans notre exemple, Camille peut comprendre rapidement une situation complexe et consacrer beaucoup de temps à une démarche administrative. Il faudra examiner chacune de ces activités, au lieu de déclarer incohérente une vie qui ne ressemble pas au portrait attaché au mot « potentiel ».

Un autre piège consiste à interpréter toute difficulté comme le signe indirect d'une supériorité. Une relation conflictuelle renseigne d'abord sur les attentes, les événements et la manière dont les personnes se répondent. Elle n'établit ni une intelligence élevée ni une intensité émotionnelle particulière. De même, un score intellectuel élevé laisse entière la possibilité d'une souffrance qui mérite d'être examinée.

Le terme « zone grise » ne désigne pas un territoire où tout se vaudrait. Certaines notions sont mieux définies et mieux étudiées que d'autres. On peut établir ces différences de solidité sans mépriser les expériences qui s'expriment à travers des termes imprécis. L'exigence consiste à maintenir ensemble l'accueil de la plainte et l'examen de l'explication proposée.

Pour Camille, une description fonctionnelle préciserait les stimulations qui deviennent envahissantes, les circonstances des émotions intenses et les tâches intellectuelles aisées ou difficiles. Elle conserverait plusieurs pistes pour comprendre la souffrance,

en examinant le sommeil, les relations et les autres éléments de sa situation.

Ce chapitre marque une étape importante dans la méthode du livre. Toutes les étiquettes n'ont pas le même statut. Certaines sont des diagnostics définis par des classifications cliniques. D'autres sont des descriptions psychométriques, des traits étudiés en psychologie ou des termes populaires. Les traiter comme s'ils possédaient la même validation crée une illusion de précision.

À ce stade, la description fonctionnelle gagne une information supplémentaire : le statut de ce qui est consigné. Diagnostic, score de test, auto-description, observation d'un proche et hypothèse explicative n'ont pas la même portée. Les juxtaposer en conservant leur provenance évite la confusion tout en préservant ce que chacun apporte.

Pour Camille, la carte pourrait distinguer un résultat d'évaluation, une difficulté rapportée et une interprétation personnelle. Le résultat concerne les aptitudes mesurées. La difficulté concerne, par exemple, certaines situations de bruit. L'interprétation affirme qu'un même mécanisme relie les deux. Conserver ces trois niveaux permet de discuter l'hypothèse sans retirer leur réalité aux deux premières informations. Le livre adoptera cette discipline chaque fois qu'une étiquette promettra d'en dire davantage que les éléments disponibles.



Chapitre 7.

Profils croisés et comorbidités

Des réalités qui se rencontrent,
pas des cases qui s'additionnent

Des chemins
qui se croisent,
pas des étiquettes
qui s'empilent

Une personne,
plusieurs facettes,
une même
humanité

TDHA
TSA
DYS
HPI
HPE
Hypersensibilité
Troubles anxieux
Troubles de l'humeur
...

Des profils
différents,
des réalités
qui s'entrelacent

Des interactions
complexes
Des symptômes
qui se chevauchent
Des parcours
uniques

Même cerveau
Des fonctionnements
multiples
Des besoins spécifiques
Un potentiel réel

COMPRENDRE
PRENDRE EN COMPTE
ADAPTER
SOUTENIR
OUVRIR DES POSSIBLES

SCOLARITÉ
TRAVAIL
RELATIONS
SANTÉ MENTALE
ESTIME DE SOI
QUALITÉ DE VIE

Des outils
pour avancer
à son rythme

— Les Esprits pluriels —

Comprendre la neurodiversité sans réduire les personnes à un diagnostic

Chapitre 7. Profils croisés et comorbidités

Imaginons Ana, qui peine à suivre une conversation bruyante, oublie des consignes, évite certaines interactions et lit lentement. Plusieurs explications sont possibles. Une seule étiquette semblerait offrir un récit plus simple, mais cette simplicité doit être confrontée à l'histoire de chaque difficulté.

L'autisme et le TDAH peuvent être associés lorsque l'évaluation établit les critères de chacun. Leur coexistence demande notamment de distinguer les manifestations communes de celles qui justifient deux diagnostics. Une revue parue en ligne en 2025 puis en volume en 2026 rappelle cette exigence. [24]

Ce qui se ressemble et ce qui s'associe

Le mot « comorbidité » désigne la coexistence de troubles chez une personne. Il ne dit pas, à lui seul, pourquoi ils se rencontrent ni comment leurs effets se combinent. Une association peut être étudiée au niveau d'un groupe, tandis que l'évaluation individuelle doit établir ce qui est présent chez la personne. La revue consacrée à l'autisme et au TDAH souligne l'intérêt de distinguer leurs caractéristiques communes et leurs particularités cliniques. [24]

Dans une conversation, manquer une information peut correspondre à plusieurs événements. Ana a peut-être mal entendu la phrase, compris seulement une partie, perdu l'information en mémoire ou préparé sa réponse au même moment. Plusieurs de ces événements peuvent se combiner. La conduite visible renseigne peu sur leur succession. L'analyse doit situer le moment où la difficulté apparaît et vérifier dans quelles autres situations elle se retrouve.

Cette démarche interdit une arithmétique naïve des diagnostics. Deux catégories ne produisent pas nécessairement deux ensembles de difficultés séparables. Une même activité peut être affectée par plusieurs obstacles, et un même appui peut en réduire une partie. Le portrait devient plus fidèle lorsque l'on

décrit leurs relations dans la vie quotidienne, plutôt que d'aligner des listes de caractéristiques censées s'additionner.

Cette difficulté se comprend facilement avec l'attention. Une personne autiste peut sembler inattentive parce qu'elle est absorbée par un intérêt, submergée par le bruit ou en difficulté pour interpréter une consigne sociale. Une personne avec TDAH peut interrompre une conversation ou perdre le fil pour d'autres raisons. Chez certaines personnes, les deux ensembles de caractéristiques coexistent. L'observation extérieure reste insuffisante pour attribuer une cause.

Les troubles d'apprentissage ajoutent encore une couche. Une lenteur dans un devoir peut provenir du décodage, de l'organisation, de la motricité, de l'attention ou de plusieurs composantes en même temps. Un score final additionne souvent ces difficultés sans les distinguer. Le rôle de l'évaluation consiste en partie à décomposer cette performance globale.

Les associations ne concernent pas seulement les troubles du neurodéveloppement. L'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil ou d'autres problèmes de santé peuvent modifier le fonctionnement quotidien et compliquer la lecture du tableau. Certaines difficultés apparaissent comme conséquences d'années d'échec ou de rejet. D'autres possèdent leur propre trajectoire. Les distinguer change les priorités de soutien. [4]

L'histoire temporelle apporte ici des indications. Une difficulté présente depuis l'enfance et une autre apparue après un changement de vie orientent vers des questions différentes. Leur coexistence actuelle reste compatible avec plusieurs origines et avec des influences réciproques. Pour Ana, une période de sommeil dégradé peut compliquer une activité déjà coûteuse, tandis que l'accumulation des difficultés peut à son tour perturber son repos. Cette possibilité mérite d'être examinée dans son cas avant de lui attribuer un mécanisme.

Le risque d'attribuer toute nouvelle plainte au diagnostic connu mérite une vigilance particulière. Si une personne autiste se replie davantage, si un adulte avec TDAH devient inhabituellement fatigué ou si un enfant ayant un trouble du langage change brusquement de comportement, l'évolution demande une attention propre. Le diagnostic antérieur fournit du

contexte. Il ne dispense pas de rechercher un problème de santé, une douleur ou un événement nouveau. [9]

Choisir une priorité sans effacer le reste

Lorsque les difficultés se multiplient, une liste exhaustive peut devenir inutilisable. Une famille peut recevoir plusieurs objectifs, chacun raisonnable isolément, dont l'ensemble occupe tout le temps disponible. La coordination consiste alors à déterminer ce qui est prioritaire pour la sécurité, le bien-être et la participation, puis ce qui peut être introduit progressivement. Le nombre d'exercices proposés n'est pas une mesure suffisante de la qualité du soutien.

Dans une situation fictive, Ana souhaite reprendre une formation. Le problème le plus urgent est peut-être l'accès aux supports de cours, ou la possibilité de dormir suffisamment, ou l'organisation du trajet. Aucune règle générale ne permet de choisir à sa place. Les professionnels peuvent apporter des évaluations et des options. Ana et les personnes qui l'aident savent aussi quelles exigences sont réalistes dans sa semaine. Une priorité devient utile lorsqu'elle permet une action faisable et une observation de ses conséquences.

Les profils croisés montrent aussi pourquoi une intervention conçue pour une difficulté peut en aggraver une autre. Un environnement très stimulant peut aider une personne à rester éveillée et concentrée tout en augmentant une surcharge sensorielle. Une routine stricte peut soutenir l'organisation et devenir pénible lorsqu'elle laisse trop peu de marge aux imprévus. Une consigne brève peut réduire la charge attentionnelle mais devenir ambiguë pour quelqu'un qui a besoin d'explicitation.

Les compromis apparaissent souvent à cette échelle. Une consigne très détaillée réduit l'incertitude au prix d'une quantité de lecture plus importante. Une présentation en deux niveaux peut séparer l'étape immédiate des informations complémentaires. De même, un environnement silencieux facilite certaines tâches tout en isolant d'échanges utiles, ce qui peut conduire à prévoir un temps de communication distinct. Ces

solutions illustrent une méthode de raisonnement et demandent une adaptation à chaque situation réelle.

La contradiction apparente entre besoin de nouveauté et besoin de prévisibilité peut elle-même être précisée. Une personne peut apprécier la nouveauté lorsqu'elle la choisit, tout en étant déstabilisée lorsqu'elle intervient au milieu d'une action engagée. Il n'est pas nécessaire d'inventer deux personnalités pour comprendre cette différence. L'initiative, le moment et la possibilité de se préparer appartiennent à la situation. Les inscrire dans le portrait rend compatibles des observations que l'étiquette seule semblait opposer.

Une personne peut rechercher la nouveauté tout en souffrant des changements imposés, aimer les relations et avoir besoin d'une longue récupération après les interactions, ou comprendre rapidement un concept puis nécessiter un soutien important pour l'appliquer dans une tâche quotidienne. La recherche d'une cohérence parfaite entre tous ses traits devient alors contre-productive.

Une coordination réussie doit aussi limiter la répétition des démarches. Raconter plusieurs fois son histoire, reconstituer les documents et répondre à des attentes différentes représente un travail. Une synthèse claire peut aider les intervenants à partager les informations pertinentes, avec l'accord de la personne et dans les limites utiles. Elle ne doit pas devenir un fichier total sur sa vie. La circulation de l'information doit répondre à une question concrète et respecter la place de celui ou celle qu'elle décrit.

Les profils croisés rendent enfin visible une limite de notre goût pour les explications élégantes. Une vie peut demander plusieurs réponses de nature différente. Un soin, une aide technique et un changement d'organisation peuvent avoir chacun leur place. Leur cohérence se juge à ce qu'ils permettent ensemble, et non à leur capacité à entrer dans une théorie unique.



Chapitre 8. Compensation, camouflage et fatigue

Pendant des années, Jeanne a appris à préparer ses conversations. Elle mémorise des réponses possibles, observe la manière dont les autres saluent, plaisantent ou terminent un échange, puis ajuste son comportement. Ses collègues la trouvent sociable. À la fin d'une journée de réunions, elle rentre pourtant épuisée et annule souvent ses activités du soir. Jeanne est fictive. Son histoire met en évidence une distinction utile : réussir une situation et pouvoir la traverser sans coût excessif sont deux mesures différentes.

Le camouflage social a été particulièrement étudié dans l'autisme. La revue de Cook et de ses collègues relève une association entre des efforts de camouflage davantage rapportés et une moins bonne santé mentale. Elle souligne aussi les limites des mesures et de la représentativité des participants. [16] Une association ne suffit pas à établir une direction causale unique.

L'effort que les autres ne voient pas

La distinction entre compensation et camouflage dépend en partie de l'objectif de la stratégie. Jeanne peut préparer ses questions pour se sentir plus à l'aise et obtenir les informations dont elle a besoin. Elle peut aussi surveiller ses gestes pour éviter d'être perçue comme différente. Ces activités se recouvrent parfois. Les séparer trop rigide ment ferait perdre la complexité de son expérience, tandis que les confondre empêcherait de comprendre ce qu'elle souhaite conserver ou changer.

Dans les travaux sur le camouflage, certaines mesures reposent sur la manière dont les personnes décrivent leurs efforts. D'autres examinent un écart entre des caractéristiques évaluées et une présentation visible. La revue de Cook et de ses collègues souligne cette diversité de méthodes et les limites de

représentativité des échantillons. [16] Une personne qui dit faire beaucoup d'efforts et un observateur qui remarque peu de signes n'apportent pas deux résultats interchangeables.

On peut imaginer Jeanne préparant une réunion en répétant ses réponses et en vérifiant l'ordre du jour. La réunion se passe bien. Ce succès inclut le travail de préparation qui l'a rendu possible, mais il ne renseigne pas encore sur son coût. Celui-ci dépend de ce qu'elle en retire, de l'effort fourni et de la possibilité de maintenir cette stratégie dans les conditions de sa vie.

Le concept de compensation dépasse l'autisme. Une personne peut compenser une difficulté de lecture en préparant longtemps les documents, une fragilité attentionnelle en utilisant de nombreux rappels ou une mémoire de travail limitée en externalisant systématiquement les étapes. Ces stratégies peuvent être très efficaces. Elles deviennent invisibles lorsqu'on juge uniquement le résultat.

Cette invisibilité produit un paradoxe. Plus une stratégie fonctionne, moins l'entourage perçoit le besoin qui l'a rendue nécessaire. Un étudiant qui remet tous ses travaux dans les délais peut sembler n'avoir aucun problème d'organisation alors qu'il sacrifie ses nuits. Un salarié qui ne commet jamais d'erreur peut vérifier chaque tâche quatre fois. Une personne qui paraît à l'aise socialement peut préparer mentalement chaque interaction.

La réussite peut ainsi produire une attente nouvelle. Parce que Jeanne a tenu une première présentation, on lui en confie plusieurs la même semaine. Le groupe généralise une observation sans avoir vu les conditions de sa réalisation. Dans cet exemple, le problème ne se situe plus seulement dans la tâche. Il réside aussi dans la manière dont une performance ponctuelle devient une disponibilité supposée permanente. La conversation devra porter sur la fréquence et la récupération, pas uniquement sur la capacité à faire une fois.

Le même raisonnement vaut pour les soutiens familiaux. Si un adolescent rend ses devoirs grâce à une présence quotidienne, le travail remis ne mesure pas son autonomie complète. Il témoigne d'un fonctionnement soutenu. La personne qui accompagne peut elle aussi être fatiguée. Rendre ce soutien visible permet de

discuter sa répartition et sa continuité. Cela évite que le succès final serve de preuve qu'aucune aide n'est nécessaire.

L'épuisement demande une enquête propre

Le terme « épuisement autistique » s'est développé pour décrire certaines expériences de fatigue profonde, de réduction des capacités et de difficulté accrue face aux stimulations. L'étude qualitative de Raymaker et de ses collègues, menée avec des adultes autistes, a contribué à préciser ce concept. [17] Ce type de recherche donne accès à des récits et à une proposition de compréhension. Il ne fournit pas, à lui seul, un test permettant d'attribuer toute fatigue à ce mécanisme.

Lorsqu'une personne perd des capacités auparavant disponibles ou présente un épuisement durable, l'enquête doit préciser les changements récents dans l'activité, le sommeil, la santé et les conditions de vie, ainsi que les symptômes nouvellement apparus. Le vocabulaire trouvé pour raconter l'expérience peut aider à la faire entendre. Il doit laisser ouverte l'évaluation d'autres causes et des soins pertinents. Une explication refermée trop tôt peut retarder cette compréhension.

La fatigue ne possède pourtant aucune cause unique. Un épuisement après une journée difficile peut dépendre du sommeil, du stress, de la douleur, de l'humeur, de la charge sensorielle, des efforts de contrôle ou de nombreux autres facteurs. Le vocabulaire du camouflage devient trompeur s'il absorbe toute forme de fatigue chez les personnes neurodivergentes. Le mécanisme doit être décrit avant d'être nommé.

Une bonne adaptation cherche davantage qu'une performance visible. La soutenabilité se juge dans la durée de maintien de la stratégie, son coût de récupération, ses effets sur les autres activités importantes et la marge de choix laissée à la personne. Une stratégie efficace à court terme peut devenir intenable si elle exige un effort permanent pour éviter le rejet.

Cette soutenabilité inclut ce que l'activité laisse possible après elle. Jeanne peut assurer ses réunions au prix d'une énergie qui manque ensuite pour voir ses proches, préparer un repas ou pratiquer une activité choisie. Le bilan d'une journée gagne à

englober ce qui suit la sortie du bureau. Le livre assume ici un choix d'analyse centré sur la vie entière, où la fatigue est appréciée avec les coûts et les possibilités qu'elle modifie.

Pour Jeanne, quelques repères suffisent : les journées qui demandent une récupération plus longue, les appuis utiles et les contraintes qu'elle souhaite réduire. La collecte doit rester supportable, surtout lorsqu'elle est déjà épuisée.

Cette perspective évite aussi de condamner toute compensation. Certaines stratégies augmentent l'autonomie et correspondent aux préférences de la personne. Utiliser un agenda, répéter une phrase avant un appel ou réduire les stimulations peut être utile sans représenter une forme d'aliénation. Le problème apparaît lorsque la stratégie devient rigide, épuisante ou imposée au détriment du bien-être.

Choisir ce qui peut devenir plus facile

La réduction du camouflage n'est pas une consigne universelle que l'on pourrait appliquer sans regarder le milieu. Une stratégie peut protéger quelqu'un dans un environnement où la différence expose au rejet. Renoncer à cette protection peut avoir des conséquences. La question utile est de savoir quelles conduites la personne souhaite pouvoir relâcher, avec qui et dans quelles conditions. Le changement concerne alors aussi la sécurité de la relation et la réponse du groupe.

Une organisation peut agir sans demander un récit intime. Elle peut rendre certaines attentes explicites, éviter de confondre contact visuel et écoute, proposer une manière de demander une pause ou permettre une réponse écrite lorsqu'elle convient à l'objectif. Ces propositions doivent être examinées dans leur contexte. Leur intérêt est de réduire l'obligation de deviner et de surveiller en permanence sa conformité, tout en maintenant les exigences nécessaires à l'activité commune.

Jeanne peut garder les préparations qu'elle juge utiles et abandonner d'autres efforts devenus trop coûteux. L'autonomie comprend cette marge de décision.



Chapitre 9. L'école : apprendre ou prouver que l'on sait apprendre

Un contrôle de deux pages peut mesurer bien plus que la connaissance annoncée. Il demande de lire les consignes, sélectionner les informations pertinentes, gérer le temps, résister aux distractions, écrire assez vite, tolérer le bruit de la salle et comprendre ce que l'enseignant attend. Lorsqu'un élève échoue, le score rassemble toutes ces composantes dans un même nombre.

Cette réalité explique une partie du débat sur les aménagements. Leur objectif peut être de réduire une exigence périphérique afin de mieux mesurer la compétence visée. Lire une consigne à voix haute, disposer d'un environnement moins distracteur ou utiliser un outil numérique peut changer la tâche. Encore faut-il savoir ce que l'on cherche à évaluer.

Ce que l'exercice cherche à évaluer

Prenons un exercice fictif de sciences. L'objectif annoncé est de comprendre pourquoi une plante a besoin de lumière. L'élève doit lire un long énoncé, recopier une partie du texte, dessiner un dispositif et répondre en quelques minutes. Une mauvaise note peut résulter d'une compréhension insuffisante du phénomène, d'une difficulté de lecture ou d'une écriture trop lente. Ces possibilités ne s'excluent pas. Les distinguer permet de choisir ce qui doit être enseigné, soutenu ou évalué autrement.

Lire l'énoncé à l'élève change de fonction selon que l'on évalue le décodage ou la compréhension scientifique. La présence d'un diagnostic ne suffit pas à trancher. La décision dépend de la compétence visée et des autres exigences introduites par l'exercice. Une évaluation plus accessible peut demander davantage de préparation à l'enseignant et fournir une information plus utile sur ce que l'élève sait réellement.

Apprendre et montrer ce que l'on a appris sont également deux activités distinctes. Pendant l'apprentissage, l'aide peut

soutenir une étape encore fragile. Au moment de l'évaluation, il faut décider quelle autonomie est attendue et pourquoi. Une même aide peut être pertinente dans les deux cas, dans un seul, ou demander une adaptation. La discussion gagne à porter sur ces objectifs plutôt que sur une opposition générale entre exigence et bienveillance.

Les recherches disponibles invitent à éviter les recettes. La synthèse de Lovett et Nelson, publiée en 2021, souligne le peu d'études expérimentales soutenant plusieurs aménagements scolaires courants pour le TDAH et la difficulté à établir un bénéfice spécifique à ces élèves. [18] La revue de Leifler et de ses collègues, consacrée aux élèves autistes en milieu ordinaire, décrit une littérature hétérogène et encore insuffisante pour des conclusions générales. [19]

PORTÉE DES DONNÉES DISPONIBLES

Le manque d'études expérimentales solides sur certains aménagements ne signifie pas qu'ils sont inefficaces pour chaque élève. Il distingue une preuve encore insuffisante d'une preuve d'inefficacité. La décision éducative reste liée à la compétence visée, aux effets observés et à la situation de l'élève. [18] [19]

Observer un changement sans transformer la classe en laboratoire

Pour une adaptation simple, l'équipe peut définir un objectif compréhensible. Un élève doit pouvoir commencer son travail sans attendre plusieurs rappels, terminer une activité donnée ou participer sans quitter la salle en détresse. Ces critères servent à regarder ce qui change. Ils n'épuisent pas sa vie scolaire. Le retour de l'élève, l'observation de l'enseignant et l'effet sur le reste de la journée peuvent apporter des informations complémentaires.

Les ajustements doivent rester réalisables. Une consigne parfaitement individualisée pour chaque moment de la journée peut dépasser les moyens disponibles. Cela conduit à chercher ce qui peut être rendu plus clair pour toute la classe et ce qui demande un soutien particulier. Une procédure commune de présentation des devoirs peut réduire certaines ambiguïtés. Un

élève peut avoir besoin en plus d'un accompagnement humain ou d'un outil spécifique. L'uniformité et l'individualisation ne sont pas les seules options possibles.

Cette incertitude n'interdit pas d'agir. Elle impose d'observer les effets recherchés et les conséquences secondaires. Avec davantage de temps, un élève peut terminer plus de questions, commettre moins d'erreurs ou prolonger une stratégie inefficace. Un casque peut réduire le bruit et améliorer la concentration tout en coupant l'élève d'informations importantes. L'évaluation de l'adaptation porte sur ces effets concrets.

L'école rencontre également les limites des catégories. Deux élèves avec le même diagnostic peuvent avoir besoin d'ajustements opposés. L'un travaille mieux avec des consignes courtes, l'autre a besoin de détails. L'un se concentre mieux près de l'enseignant, l'autre souffre davantage des mouvements visibles à cet endroit. L'un bénéficie d'une routine stable, l'autre se démotive lorsque les tâches deviennent trop prévisibles.

La coopération entre l'élève, la famille, les enseignants et les professionnels peut réduire ces erreurs d'ajustement. Elle ne garantit pas l'accord. Les priorités diffèrent. Une école peut privilégier la gestion du groupe, un parent la réduction de la souffrance, un professionnel l'apprentissage d'une compétence, l'élève la possibilité de rester avec ses amis. Ces objectifs méritent d'être rendus explicites.

La place de l'élève dans les décisions

L'élève peut savoir qu'une aide fonctionne tout en refusant de l'utiliser devant ses camarades. Ce refus mérite d'être compris. Peut-être l'outil le distingue-t-il d'une manière qu'il vit mal, peut-être est-il difficile à utiliser ou ralentit-il une autre activité. L'explication par le manque de coopération ferme trop vite l'échange. On peut examiner une autre présentation, une autre modalité ou un objectif plus acceptable, sans présumer la raison de son refus.

La parole de l'élève n'a pas besoin de prendre la forme d'une analyse élaborée pour compter. Il peut montrer les moments les plus difficiles, comparer deux situations ou désigner l'aide qu'il souhaite garder. Pour ceux dont l'expression est limitée, les

moyens de communication et l'observation attentive prennent une place plus importante. Les adultes doivent alors reconnaître ce qu'ils savent, ce qu'ils infèrent et ce qu'ils ne peuvent pas encore interpréter.

L'école est aussi un lieu de relations. Une adaptation qui améliore la réalisation d'un exercice peut réduire la participation à un groupe si elle isole systématiquement l'élève. À l'inverse, le maintien dans le groupe peut devenir très coûteux si aucun soutien n'est disponible. Ces tensions ne se résolvent pas par une formule générale. Elles demandent de regarder ce qui est appris, les relations rendues possibles et les effets sur la personne dans la durée.

L'environnement scolaire peut aggraver des difficultés sans en être l'origine. Une classe bruyante augmente la charge d'un élève sensible aux stimulations. Une organisation très fragmentée met davantage à l'épreuve la planification. Un enseignement explicite peut soutenir certains apprentissages. Ces effets renseignent surtout sur les conditions dans lesquelles cet élève apprend réellement, plutôt que sur l'étiologie de ses difficultés.

Le passage d'une classe à une autre mérite une attention propre. Un fonctionnement devenu stable peut dépendre d'un enseignant qui annonce les transitions, d'un camarade qui aide à retrouver une consigne ou d'un local peu bruyant. Si ces conditions disparaissent, la difficulté peut réapparaître. Transmettre quelques informations utiles sur les aides efficaces permet de ne pas recommencer toute l'enquête. Cela suppose un accord sur ce qui doit circuler et sur la manière de présenter l'élève sans le réduire à ses difficultés.

L'histoire scolaire peut comporter des retards de compréhension et des interprétations erronées. Leur analyse gagne à identifier les responsabilités et les contraintes à chaque étape. Une enseignante peut manquer d'information, une famille d'accès à une évaluation, un service de disponibilité. Décrire la procédure qui laisse un besoin sans réponse renseigne davantage qu'une accusation générale contre « l'école » et aide à préciser les améliorations possibles.

La réussite éducative ne devrait enfin pas se limiter au nombre d'exercices terminés. On peut examiner ce que l'élève comprend,

ce qu'il retient, les activités auxquelles il participe et le coût de sa journée. Ces dimensions ne seront pas toujours faciles à concilier. Elles rendent néanmoins visible ce qu'une note isolée laisse de côté. Pour certains élèves, un progrès modeste dans une activité choisie ou une communication plus fiable constitue une évolution importante, même s'il se traduit peu dans les classements scolaires.

Le livre défend ici une orientation éducative : rendre les attentes assez précises pour distinguer ce qui sert l'apprentissage de ce qui ajoute un obstacle évitable. Cette orientation n'est pas la conclusion automatique d'une étude. Elle s'appuie sur une conception de l'école où la diversité des moyens d'accès doit pouvoir coexister avec l'ambition des savoirs transmis.



Chapitre 10. Le travail : quand l'organisation rencontre le fonctionnement

Le monde professionnel transforme souvent des capacités ordinaires en exigences intensives. Une journée peut réunir concentration prolongée, réunions, interruptions, délais multiples, communications implicites, changements de priorité et bruit ambiant. Ce mélange explique pourquoi certaines personnes découvrent tardivement l'ampleur de leurs difficultés. Elles avaient trouvé des environnements compatibles jusqu'au moment où le travail a changé.

L'emploi offre aussi davantage de possibilités de spécialisation que l'école. Une personne peut choisir un métier qui s'appuie fortement sur ses intérêts, éviter certaines tâches ou construire des routines très efficaces. Cette sélection peut masquer des difficultés pendant des années. Une promotion, un nouvel espace de travail ou l'arrivée d'un logiciel mal conçu suffit parfois à faire apparaître un retentissement jusque-là limité.

Les conditions réelles d'un poste

Une fiche de fonction décrit souvent des résultats attendus et laisse implicites les conditions de leur production. « Gérer les demandes » peut signifier répondre à une file organisée ou arbitrer en permanence entre plusieurs messages urgents. « Travailler en équipe » peut désigner une coopération planifiée ou une disponibilité immédiate à toute interruption. Ces différences changent l'activité. Les rendre visibles permet d'examiner les besoins sans attribuer trop vite la difficulté à une incapacité générale.

Nora accomplit correctement son travail d'analyse et peine depuis qu'elle doit répondre simultanément à trois canaux de communication. Le poste a changé, et la discussion peut se concentrer sur les demandes qui exigent réellement une réponse

immédiate, les moments de concentration et la personne qui arbitre les priorités lorsqu'elles se contredisent.

Dans cette situation, l'employeur pourrait convenir avec Nora de plages pendant lesquelles un canal reste prioritaire et les autres attendent. Cette proposition d'organisation doit être évaluée dans son contexte et ne garantit aucune équité absolue. Elle cherche à relier le changement à l'obstacle observé, tout en tenant compte des effets sur le travail de l'équipe.

Une revue systématique publiée par Cécile Heinze en décembre 2025 réunit dix études sur les aménagements et les résultats professionnels chez des adultes autistes. Elle décrit plusieurs formes de soutien et des résultats encourageants, avec des limites de méthode et des échantillons restreints. [20]

L'expérience concrète montre pourquoi la qualité relationnelle compte. Une consigne écrite aide peu si elle arrive après trois changements informels communiqués dans un couloir. Un bureau calme ne compense pas des priorités contradictoires. Un horaire flexible peut réduire la fatigue pour une personne et désorganiser complètement une autre. L'aménagement utile vise une difficulté précise dans une organisation réelle.

L'aménagement comme accord de travail

Un ajustement gagne à être formulé concrètement. « Moins d'interruptions » peut recouvrir des attentes très différentes. Un accord peut préciser les moments réservés à une tâche, le canal utilisé en cas d'urgence et la manière de signaler qu'une priorité change. Il devient alors possible d'examiner si l'activité reste coordonnée. L'aménagement ne dépend plus uniquement de la bonne volonté supposée de chacun.

La prévisibilité compte aussi pour les collègues. Si Nora protège une plage de concentration sans qu'un autre mode de contact soit prévu, une difficulté peut être déplacée vers l'équipe. À l'inverse, si toute demande se présente comme urgente, la plage protégée reste fictive. Le compromis doit identifier ce qui est nécessaire au service et ce qui résulte d'une habitude. Les conflits gagnent à être discutés à ce niveau plutôt qu'à travers des jugements sur la motivation ou la souplesse des personnes.

Une adaptation conserve aussi un coût organisationnel possible. Modifier les horaires, changer un espace ou répartir autrement une tâche peut déplacer une charge vers les collègues. Cet effet mérite d'être examiné ouvertement. Son intérêt dépend de l'obstacle visé, de ce que le changement produit et de la possibilité d'une organisation acceptable pour les personnes concernées.

Le diagnostic intervient ici de plusieurs manières. Il peut donner accès à des droits selon la législation applicable, légitimer une demande ou aider la personne à comprendre son propre fonctionnement. Il peut aussi exposer à des stéréotypes, surtout lorsque l'entourage professionnel connaît mal le trouble. La décision de divulguer un diagnostic dépend du contexte, des protections juridiques, des besoins et des préférences de la personne.

Une demande d'ajustement peut parfois être formulée à partir d'un besoin fonctionnel sans raconter toute son histoire médicale. Les exigences juridiques et les voies d'accès aux dispositifs varient selon les pays et les situations. Elles doivent être vérifiées auprès des interlocuteurs compétents. Le présent raisonnement porte sur l'information nécessaire à la décision, les personnes qui doivent y avoir accès et les conditions de confidentialité.

La divulgation d'un diagnostic relève d'un choix situé, plutôt que d'un test de courage ou de confiance. Une personne peut partager cette information, la réserver à certains interlocuteurs ou différer sa décision selon les risques, les bénéfices et ses besoins. Une organisation aide ce choix lorsqu'elle rend ses procédures suffisamment claires pour réduire les suppositions.

Une politique d'inclusion efficace ne peut pas reposer uniquement sur la bonne volonté individuelle. Les procédures de recrutement, la manière d'annoncer les priorités, l'organisation des réunions et la possibilité de travailler dans différents environnements façonnent l'accessibilité. Certaines pratiques profitent à de nombreux salariés sans nécessiter de connaître leur diagnostic. D'autres adaptations doivent rester personnalisées.

Le risque d'un discours trop optimiste apparaît ici avec force. Un environnement bien conçu n'efface pas toutes les limitations.

Certaines personnes ne peuvent travailler qu'un nombre réduit d'heures, ont besoin d'un accompagnement durable ou rencontrent des difficultés qui persistent malgré des adaptations importantes. Mesurer la réussite uniquement par l'accès à l'emploi reproduirait le même défaut que mesurer l'école uniquement par les notes.

La durée et les possibilités de vie

Un poste peut convenir par son contenu et rester intenable par son rythme. La charge comprend les trajets, la récupération, les obligations extérieures et la fréquence des imprévus. Une semaine exceptionnelle ne décrit pas une capacité permanente. Lorsque l'on évalue un ajustement, il faut regarder s'il permet de tenir dans le temps sans déplacer tout le coût hors du travail. Cette manière de juger la réussite engage une conception de la santé et de la participation qui dépasse la seule productivité.

Les personnes éloignées de l'emploi doivent rester présentes dans cette réflexion. Certaines souhaitent travailler et rencontrent des obstacles qui pourraient être réduits. D'autres ont besoin de formes de participation ou de soutien différentes. La diversité cognitive oblige à dissocier la valeur d'une existence de la capacité à occuper un poste. Le besoin d'aide conserve sa légitimité indépendamment d'un gain de rentabilité.

Le soutien aux personnes ayant des besoins importants comporte des questions très matérielles : l'accompagnement des démarches, le remplacement d'un proche indisponible et la continuité des aides pendant une transition. Moins visibles que les programmes de recrutement spécialisés, ces conditions déterminent pourtant des possibilités quotidiennes. Une politique de participation doit les traiter sans exiger des personnes aidées qu'elles deviennent d'abord des exemples de réussite.

Dans le monde professionnel, la soutenabilité se juge dans la durée. Une tâche possible pendant une heure peut devenir intenable huit heures par jour, et un rythme acceptable pendant une semaine conduire à un épuisement après plusieurs mois. Pour Nora, distinguer les demandes réellement urgentes des autres suffit à former une première hypothèse d'organisation,

dont les effets devront être observés dans le temps et pour l'équipe.



Chapitre 11. Diagnostiquer sans enfermer

Recevoir un diagnostic peut produire des effets très différents. Pour certains, il met fin à des années d'incompréhension. Il donne un vocabulaire, facilite l'accès à des soins et replace une histoire personnelle dans un cadre plus large. Pour d'autres, il arrive avec la crainte d'être réduit à une catégorie, d'être jugé incapable ou de voir chaque comportement interprété à travers le même prisme.

Ces expériences peuvent coexister chez une même personne. Un diagnostic apporte une information et transforme aussi la manière dont cette information circule. Les recommandations NICE sur le TDAH invitent à discuter les bénéfices possibles ainsi que les risques de stigmatisation et d'étiquetage. [5]

Ce qu'un diagnostic apporte à une histoire

Un diagnostic peut modifier le récit d'un parcours. Un adulte reconsidère certaines remarques scolaires, une famille comprend autrement des conflits anciens, une personne trouve des interlocuteurs qui connaissent des difficultés proches. Ces réinterprétations peuvent avoir de la valeur sans devenir des preuves rétrospectives de chaque événement. Le présent fournit une nouvelle hypothèse de lecture. Le passé conserve ses lacunes et la pluralité de ses causes possibles.

Le soulagement constitue une réaction possible parmi d'autres. Une personne peut éprouver de l'incertitude, de la colère ou très peu de changement immédiat. La manière dont le diagnostic est annoncé, les explications disponibles et les aides accessibles façonnent cette expérience. Un temps d'appropriation peut être nécessaire avant de savoir quelle place donner au mot. Une catégorie clinique décrit une situation, elle ne prescrit aucune réaction émotionnelle.

L'annonce devrait rendre compréhensible le raisonnement qui conduit à la conclusion, notamment les informations réunies, les autres possibilités examinées et la portée du résultat pour les difficultés actuelles. Cette compréhension aide la personne à situer le diagnostic dans son histoire sans transformer chaque épisode passé en preuve rétrospective.

Diagnostic et identité ne se confondent pas. Une catégorie clinique rassemble des manifestations selon des critères, soutient la communication professionnelle et mobilise des connaissances issues de groupes étudiés. La place qu'une personne donne ensuite à ce diagnostic dans son identité lui appartient, et la catégorie ne prédit pas le détail de sa vie.

Une carte sans diagnostic aurait également ses limites. Décrire uniquement des dimensions pourrait faire perdre des connaissances utiles sur l'évolution, les associations fréquentes, les interventions étudiées et certains risques. Elle pourrait aussi compliquer l'accès aux dispositifs qui utilisent des critères administratifs ou médicaux. La personnalisation devient plus solide lorsqu'elle s'appuie sur les catégories disponibles sans leur demander davantage qu'elles ne peuvent fournir.

L'incertitude fait partie de l'évaluation

Deux personnes peuvent présenter des manifestations voisines tout en ayant des histoires différentes. Les informations peuvent manquer, les souvenirs diverger ou les signes varier selon les contextes. Un raisonnement clinique rigoureux doit pouvoir reconnaître ces limites. L'incertitude ne signifie pas que tout se vaut. Elle indique ce qui peut être conclu à partir des éléments disponibles et ce qui demande encore un examen.

Le dépistage et le diagnostic jouent ici des rôles distincts. Un questionnaire peut signaler des éléments à explorer ou structurer une discussion. Il ne remplace pas à lui seul une évaluation complète. Les recommandations NICE sur le TDAH le précisent explicitement. [5] Une personne qui se reconnaît fortement dans un questionnaire peut prendre cette reconnaissance comme un motif de consultation, sans en faire une conclusion définitive sur son fonctionnement.

Une évaluation peut ne pas retenir le diagnostic attendu tout en reconnaissant pleinement la souffrance décrite. La conclusion doit alors être expliquée, les autres pistes discutées et les difficultés identifiées prises en charge. Reconnaissance de la plainte et attribution d'une catégorie correspondent à deux actes distincts. Leur confusion peut donner à la personne l'impression qu'un mot précis conditionne le fait d'être entendue.

Cette articulation demande une discipline de langage. « Il est autiste » et « il a un diagnostic d'autisme » peuvent être préférés différemment selon les personnes. Le choix des mots compte, mais il ne remplace pas la qualité de l'analyse. Une formulation respectueuse peut encore enfermer quelqu'un dans un stéréotype si l'on suppose qu'il possède automatiquement toutes les caractéristiques associées à l'étiquette.

Le langage choisi par les personnes concernées varie. Certaines donnent au diagnostic une place importante dans leur identité ou dans leurs liens collectifs. D'autres préfèrent qu'il reste discret. Respecter ces usages demande de les écouter et de pouvoir les ajuster. La discussion sur les mots devient utile lorsqu'elle améliore la relation. Elle devient moins utile si elle sert à décider de l'extérieur quelle manière de se nommer serait seule acceptable.

Une catégorie peut aussi être utilisée par l'entourage pour anticiper des comportements qui n'ont jamais été observés. On peut présumer qu'une personne sera rigide, distraite ou douée dans un domaine parce qu'on connaît son diagnostic. Ce raccourci semble parfois bienveillant. Il prive pourtant l'échange d'informations individuelles. Demander comment une personne fonctionne dans la situation présente reste plus utile que lui attribuer le portrait moyen rencontré ailleurs.

Le diagnostic tardif pose une autre question. Lorsqu'une personne reçoit à trente ou quarante ans un mot qui réorganise son histoire, le soulagement peut être réel. Le risque de relecture totale l'est aussi. Chaque difficulté passée ne devient pas rétroactivement une conséquence certaine du trouble. Le diagnostic ouvre de nouvelles hypothèses sur le parcours, il ne fournit pas l'enregistrement de ce qui s'est passé à chaque étape.

Diagnostiquer sans enfermer demande enfin de conserver les priorités propres à la personne. Deux individus présentant des difficultés semblables peuvent vouloir des choses différentes. L'un souhaite améliorer sa tolérance aux changements pour voyager davantage. L'autre préfère organiser sa vie afin de réduire les imprévus. Une intervention pertinente ne cherche pas seulement à normaliser une conduite visible. Elle examine les objectifs, la sécurité, l'autonomie, la participation et la qualité de vie.

Les objectifs de l'accompagnement

La personne peut vouloir modifier une conduite qui lui pèse, développer une compétence, obtenir un soutien durable ou réduire une exigence environnementale dont le rapport avec l'activité reste faible. Ces demandes peuvent coexister. Un accompagnement respectueux examine leurs effets, leur faisabilité et leur sens pour la personne, sans présumer qu'une modification individuelle relève d'une normalisation abusive ou qu'une adaptation collective constitue une concession excessive.

Les désaccords sont inévitables lorsque plusieurs personnes participent aux décisions. Un proche peut craindre un risque que l'adulte concerné accepte de prendre. Un professionnel peut proposer un apprentissage dont le coût semble trop élevé à la famille. Le diagnostic ne tranche pas ces arbitrages. Il apporte des connaissances à une discussion qui doit aussi porter sur les préférences, les possibilités et les conséquences prévisibles.

Pour les personnes qui communiquent difficilement leurs choix, cette exigence devient plus importante. L'accompagnement doit rechercher une expression accessible, distinguer ce qui est observé de ce qui est interprété et réexaminer les décisions. Les objectifs incluent la sécurité, la santé, les relations et l'accès à des activités qui ont du sens pour la personne, au-delà de la seule facilité de gestion pour l'entourage.

La carte doit être reliée à une activité et à des priorités explicites. Une différence ne devient pas automatiquement un objectif de correction. La personne, les proches et les professionnels doivent pouvoir discuter ce qui relève d'un choix,

d'une souffrance, d'une limitation ou d'un risque pour elle-même ou pour autrui.

Cette articulation donne au diagnostic une place durable et limitée. Il peut ouvrir une compréhension, orienter des soins et soutenir une demande. La description fonctionnelle précise ensuite comment ces connaissances rencontrent une vie particulière. Une carte utile conservera le diagnostic lorsqu'il existe, avec sa provenance, sans lui faire occuper les cases où l'on devrait encore décrire une activité ou demander une préférence.

Chaque fonctionnement est unique. Le cartographe, c'est lui donner de l'espace, pas une case.

Une carte pour comprendre, pas pour classer.

Chapitre 12.

Cartographeur un fonctionnement

Mieux se comprendre pour mieux avancer

COGNITION

- Attention
- Mémoire
- Fonctions exécutives
- Raisonnement
- Apprentissages

ÉMOTIONS

- Régulation
- Intensité
- Sensibilité
- Expression
- Besoins

SENSORIEL

- Perceptions
- Hypersensibilités
- Hyposensibilités
- Environnement
- Besoin de calme

COMPORTEMENTS

- Habitudes
- Stratégies
- Routines
- Compensations
- Camouflage

RELATIONS

- Communication
- Interactions
- Codes sociaux
- Appartenance
- Soutien

CONTEXTE

- Famille
- École
- Travail
- Environnement
- Culture

FORCES

- Talents
- Intérêts
- Motivations
- Ressources
- Ce qui fait sens

Une vision globale d'un fonctionnement en mouvement

COMPRENDRE

AJUSTER

EXPLORER

AVANCER

Des repères pour mieux choisir, pas pour se limiter.

Ce qui semble différent peut aussi être une ressource.

OBSERVATION

RÉFLEXION

OUTILS

MISE EN PERSPECTIVE

AJUSTEMENTS

ÉVOLUTION

NEURODIVERSITÉ

PLURALITÉ

PARCOURS SINGULIERS

POSSIBLES MULTIPLES

MOI

IDÉES

SENS

DÉFIS

ÉQUILIBRE

RESSOURCES

AVENIR

DES CARTES POUR DES CHEMINS PLUS LIBRES

Les Esprits pluriels

Comprendre la neurodiversité sans réduire les personnes à un diagnostic

Cartographeur aujourd'hui pour un demain plus aligné.

71

Chapitre 12. Cartographier un fonctionnement

Depuis le début de ce livre, nous avons accumulé des informations sans leur donner de forme générale. Nous avons observé des tâches, distingué les contextes, examiné l'ancienneté des difficultés, repéré les aides, ajouté le coût de compensation et séparé les sources d'information. Le moment est venu d'assembler ces éléments.

La cartographie fonctionnelle proposée ici est un outil descriptif centré sur une activité concrète. Elle organise des informations sans produire de score global ni décider de l'appartenance à une catégorie.

Commencer par une activité importante

Une carte devient plus utile lorsqu'elle part d'un projet reconnaissable. « Améliorer mon fonctionnement » est trop large pour guider une observation. « Pouvoir participer à la réunion sans devoir reconstruire ensuite toutes les décisions » donne un point de départ. L'objectif peut être modifié au cours de l'échange. Il permet déjà de choisir les informations nécessaires et d'éviter une description exhaustive de la personne sans usage défini.

Le choix appartient autant que possible à celui ou celle qui vit la situation. Un professionnel, un enseignant ou un proche peut aider à le préciser. Il peut aussi signaler un risque ou une conséquence que la personne n'avait pas envisagée. Cette coopération demande que les rôles restent lisibles. Une carte produite pour faciliter un trajet n'a pas la même finalité qu'un document destiné à préparer une évaluation clinique ou un ajustement professionnel.

La première phrase devrait pouvoir être comprise par quelqu'un qui ignore les diagnostics. Elle décrit une activité, les conditions habituelles et le problème rencontré. Les mots techniques peuvent ensuite préciser certains éléments.

Commencer par eux risque de transformer l'observation en confirmation : tout ce qui arrive devient un exemple d'« inhibition » ou de « surcharge » avant que l'on ait décrit ce qui s'est effectivement passé.

Amine est un personnage fictif. Il doit participer chaque lundi à une réunion d'équipe de quatre-vingt-dix minutes. Il comprend bien les sujets abordés, mais perd le fil lorsque plusieurs personnes parlent rapidement. Il prend des notes pour rester engagé, ce qui l'empêche parfois d'écouter la phrase suivante. Après la réunion, il relit le compte rendu et récupère les informations manquées. La tâche est accomplie, au prix d'un effort important.

Une première couche décrit l'activité. Il ne suffit pas d'écrire « difficultés d'attention ». On précise qu'il s'agit de suivre une discussion longue, orale, rapide, avec plusieurs interlocuteurs. Une deuxième couche décrit ce qui est observé : perte du fil, difficulté à noter tout en écoutant, besoin de relecture. Une troisième couche inscrit le contexte : durée, nombre de personnes, rythme, bruit éventuel, possibilité de demander une répétition.

Viennent ensuite les ressources. Amine comprend le contenu, connaît bien son domaine et bénéficie d'un compte rendu écrit. Ces points ne sont pas décoratifs. Ils expliquent en partie pourquoi il réussit malgré la difficulté. Les supprimer du portrait donnerait l'impression que sa performance vient spontanément d'une capacité intacte.

Le coût constitue une couche supplémentaire. La carte précise l'énergie demandée par la réunion, la possibilité d'enchaîner avec une tâche complexe, le besoin éventuel d'un temps seul et la stabilité de la stratégie d'une semaine à l'autre. Cette couche évite de confondre réussite et absence de difficulté.

On ajoute ensuite la variabilité. La comparaison entre petit groupe, ordre du jour écrit, visioconférence, matin et après-midi peut faire apparaître des différences. Certaines variations deviennent des expériences naturelles. Elles ne prouvent aucune cause générale, mais révèlent les conditions qui modifient le fonctionnement de cette personne.

La dernière couche concerne les priorités. Amine peut chercher à mieux suivre les réunions, en réduire la durée, recevoir certaines informations à l'avance ou éviter qu'elles suivent une matinée déjà chargée. La carte doit conserver cette préférence pour ne pas devenir un projet de normalisation conçu par d'autres.

Ce cadre peut être résumé par huit entrées : l'activité, les manifestations observées, l'histoire, le contexte, les ressources, les aides, le coût et les priorités. Cette liste sert à guider la description, pas à imposer huit cases à remplir à chaque fois. Certaines situations exigent davantage d'informations, d'autres beaucoup moins.

Une carte située pour Amine

Le tableau suivant reprend uniquement la situation d'Amine et illustre une manière de décrire l'activité, ses conditions, les aides déjà présentes et la priorité exprimée.

Entrée	Description de la situation
Activité et objectif	Suivre la réunion du lundi et connaître les décisions qui concernent son travail
Difficulté rapportée	Perdre le fil lorsque plusieurs personnes interviennent rapidement
Conditions	Réunion longue, échanges oraux et prise de notes simultanée
Ressources	Connaissance du sujet et compréhension du compte rendu écrit
Aides déjà présentes	Compte rendu disponible après la réunion
Coût rapporté	Temps de relecture et difficulté à enchaîner avec une autre tâche exigeante
Priorité exprimée	Recevoir les sujets à l'avance et mieux distinguer les décisions prises
Question à examiner	Une préparation écrite et une synthèse des décisions pendant la réunion facilitent-elles sa participation ?

Cette carte conserve une incertitude importante : l'ancienneté de la difficulté d'Amine et sa présence dans d'autres situations restent inconnues. Une première question d'organisation peut être formulée avec cette lacune clairement indiquée. Une conclusion diagnostique demanderait en revanche un travail beaucoup plus large.

La provenance des informations doit rester identifiable. La fatigue est rapportée par Amine. La durée figure dans l'organisation de la réunion. Les décisions manquées pourraient être décrites à partir d'exemples précis. On peut rapprocher ces éléments sans les convertir en une unité commune. Un diagramme spectaculaire qui attribuerait un chiffre à chacun donnerait ici une illusion de mesure.

Supposons qu'Amine et son équipe choisissent de transmettre les sujets à l'avance et de reformuler les décisions avant de passer au point suivant. Ils peuvent convenir d'un moment pour discuter des effets, selon le rythme de leurs réunions. Amine pourra dire s'il suit mieux et si la préparation demande un travail supplémentaire. L'équipe pourra regarder si les décisions sont plus claires. L'essai répond à une question locale, sans prétendre déterminer la meilleure méthode pour toutes les personnes qui ont du mal en réunion.

Si l'amélioration est partielle, la carte doit pouvoir l'accueillir. Amine peut mieux comprendre les décisions et rester très fatigué. Il peut bénéficier du support écrit tout en trouvant le rythme oral toujours difficile. La réponse devient alors plus précise que « l'aménagement marche » ou « il ne marche pas ». On peut conserver le bénéfice obtenu et examiner la difficulté qui demeure.

Le programme RDoC du National Institute of Mental Health explore des dimensions qui peuvent traverser les catégories diagnostiques. Il est conçu pour la recherche. [21] La cartographie du livre poursuit une autre finalité : ordonner des informations quotidiennes à l'échelle d'une activité.

Une carte devient particulièrement intéressante lorsqu'elle rassemble plusieurs activités. Des régularités peuvent alors apparaître, par exemple une surcharge liée à l'arrivée simultanée d'informations, une baisse de performance en fin de journée ou

l'effet d'une aide visuelle dans des tâches différentes. Ces motifs peuvent guider une discussion avec un professionnel ou la recherche d'un aménagement.

Une autre carte pour une autre priorité

Reprenons Idriss, présenté dans le chapitre sur l'autisme. Son projet est de participer à une sortie dans un lieu qu'il apprécie. Une carte centrée uniquement sur l'attention serait peu utile. Il faut savoir comment il exprime son accord, comment le trajet est préparé, quelles informations lui sont accessibles et quelle assistance est nécessaire. La même démarche descriptive conduit ici à d'autres entrées parce que l'activité et la priorité sont différentes.

Les proches peuvent rapporter qu'Idriss accepte plus volontiers le départ lorsque l'ordre des étapes est présenté à l'avance. Cette observation décrit un comportement et gagne à être complétée par ses moyens d'expression ainsi que par l'attention portée aux variations. Un refus ponctuel peut correspondre à un changement d'avis, de la fatigue ou une difficulté nouvelle. La carte doit laisser cette possibilité ouverte au lieu d'interpréter automatiquement le refus comme l'échec de la préparation.

Le soutien nécessaire peut rester important même lorsque la sortie se déroule bien. Il faut alors le décrire comme une condition de cette participation. Une amélioration de l'accessibilité n'a pas pour objectif obligatoire de faire disparaître toute assistance. Dans cet exemple, la réussite pourrait être une sortie choisie et supportable, avec une communication plus fiable et un accompagnement disponible. Les critères retenus doivent correspondre à la vie de la personne.

Cette seconde situation montre pourquoi la cartographie ne doit pas devenir un profil universel organisé autour des performances de l'adulte autonome. Des dimensions comme l'abstraction ou la créativité peuvent intéresser certaines questions. Elles n'ont aucune raison de dominer toutes les descriptions. La priorité reste l'activité que la personne souhaite pouvoir réaliser et les conditions qui la rendent possible.

La carte doit également conserver ce qui fonctionne bien. Une approche centrée uniquement sur les difficultés reproduirait la vision déficitaire qu'elle cherche à dépasser. Les capacités stables, les environnements favorables, les intérêts, les stratégies efficaces et les relations soutenant font partie du fonctionnement. Ils deviennent d'autant plus utiles qu'on sait dans quelles conditions ils apparaissent.

Cette méthode rencontre enfin une limite décisive. Tout ce qui compte n'est pas mesurable avec la même précision. Une note scolaire, une impression de fatigue et le récit d'un proche appartiennent à des registres différents. Les réunir dans un même tableau ne leur donne pas une unité commune. La cartographie doit préserver la provenance de chaque information et son degré d'incertitude.

Statut et usages de la cartographie

Une carte utile sélectionne les informations selon sa finalité. Pour organiser une réunion, l'employeur a rarement besoin du récit détaillé de l'enfance, tandis qu'une évaluation clinique peut nécessiter certains éléments d'histoire. Cette finalité détermine ce qui mérite d'être partagé et protège la description personnelle d'une circulation générale par défaut.

La personne concernée doit pouvoir corriger le document, lorsque ses moyens d'expression le permettent, ou le réexaminer avec un soutien adapté. Une phrase rédigée par un proche reste attribuée à ce proche, et une hypothèse garde son statut. Les désaccords peuvent signaler des situations observées différemment ou des conséquences auxquelles chacun accorde un poids différent. La carte gagne à les conserver plutôt qu'à les effacer pour obtenir une présentation artificiellement homogène.

La mise à jour importe autant que la première rédaction. Une aide devient familière, une tâche change ou un problème de santé modifie les possibilités. La carte décrit une situation à un moment donné. La conserver sans date et sans contexte risquerait de figer précisément ce que la démarche voulait rendre plus fidèle. Quelques lignes datées sur une évolution utile valent parfois mieux qu'un nouveau portrait complet.

La cartographie devrait être évaluée comme tout outil proposé. Son intérêt pratique reste à étudier : facilite-t-elle le dialogue, réduit-elle les oublis d'informations importantes, demeure-t-elle compréhensible sans ajouter une charge excessive ? Sa cohérence conceptuelle ne suffit pas à établir son efficacité.

Au terme de cette démarche, une description comme celle d'Amine permet de préparer une conversation et un essai d'organisation. Celle d'Idriss peut aider à rendre une participation possible avec un soutien durable. Le diagnostic, lorsqu'il existe, apporte un autre ensemble de connaissances. L'intérêt de la carte tient à la place qu'elle laisse aux informations qu'aucun nom de catégorie ne pouvait fournir à lui seul.



Chapitre 13.

Penser une société
pour plusieurs
formes d'esprit

Plus de diversité mentale
pour un monde plus humain

Une société
qui inclut
les différences
est une société
plus riche,
plus créative
et plus résiliente.

Moins de
normes,
plus de possibles.

Écouter
Reconnaître
Respecter
Inclure
Adapter
Valoriser

Différents
fonctionnements,
une même société.

- ÉGALITÉ
- ACCESSIBILITÉ
- FLEXIBILITÉ
- DIVERSITÉ
- INCLUSION
- COOPÉRATION
- BIEN-ÊTRE

DES
ESPRITS
PLURIELS
POUR
DEMAIN

- ADAPTATION
- PLURALITÉ
- OPPORTUNITÉS
- LIENS
- AVENIR

- NEURODIVERSITÉ
- TRANSITION SOCIÉTALE
- VIVRE ENSEMBLE
- INNOVATION SOCIALE
- ENVIRONNEMENT
- SOLIDARITÉ

Ce n'est pas
à la personne
de se conformer,
mais à la société
de s'adapter.

D'autres
regards
pour un
monde plus
ouvert

Des aménagements
pour que chacun·e
puisse trouver sa place.

Des idées
diverses
pour un
même
monde

Une société plus juste
commence par la
reconnaissance
de toutes les façons
de penser.

Les Esprits pluriels

Comprendre la neurodiversité sans réduire les personnes à un diagnostic

Chapitre 13. Penser une société pour plusieurs formes d'esprit

À la fin d'un livre sur la neurodiversité, la tentation est grande de transformer chaque observation en programme de société. Les chapitres précédents ont pourtant installé une règle plus exigeante. Une étude peut montrer qu'une modification réduit une difficulté dans une population donnée. Elle ne décide pas à elle seule quelles priorités une école, une entreprise ou une collectivité doit adopter. Entre connaissance et politique se trouvent des valeurs, des ressources et des arbitrages.

Cela n'empêche pas de tirer certaines conséquences descriptives. Si les individus diffèrent fortement dans leur manière de traiter l'information, une organisation conçue autour d'un seul profil moyen produira des frictions prévisibles. Si certaines adaptations réduisent le retentissement sans nuire à l'objectif de l'activité, leur examen devient rationnel. Si des personnes ont besoin d'un soutien durable malgré un environnement accessible, l'inclusion doit aussi prévoir cette dépendance.

Des exigences à justifier

Une organisation ne peut pas adapter toutes ses règles à chaque préférence. Elle peut néanmoins expliquer ce qu'une règle cherche à rendre possible. L'obligation de disposer d'une information commune est parfois indispensable. L'obligation de la recevoir à un moment unique, uniquement à l'oral, mérite d'être examinée. La distinction permet de préserver l'objectif tout en discutant les moyens. Elle demande une connaissance du travail réel, des ressources et des conséquences pour les autres participants.

L'accessibilité peut alors devenir une propriété ordinaire des procédures. Un formulaire annonce les pièces nécessaires avant de commencer. Une démarche indique ce qui a été enregistré et ce qui manque encore. Un service permet de retrouver une

consigne après l'échange. Ces propositions semblent simples, mais leur réalisation suppose des choix de conception et du temps. Elles doivent être évaluées selon ce qu'elles rendent effectivement plus facile, pour quels usagers et à quel coût.

La flexibilité comporte elle-même des limites. Trop de possibilités sans repères peut augmenter le nombre de décisions et l'incertitude. Une personne peut préférer une procédure stable à une liberté mal définie. Concevoir pour plusieurs fonctionnements peut demander de proposer une voie claire et des variantes accessibles, plutôt que de demander à chacun de construire seul son parcours. La diversité des besoins doit être prise au sérieux jusque dans les remèdes qu'on lui propose.

Cette question produit parfois des changements simples. Une information importante peut être disponible à l'oral et à l'écrit. Une procédure peut annoncer clairement ses étapes. Un espace peut offrir plusieurs niveaux de stimulation. Une réunion peut distinguer ce qui exige une discussion synchrone de ce qui peut être traité autrement. Ces pratiques aident certaines personnes neurodivergentes et peuvent améliorer la lisibilité pour beaucoup d'autres.

Une accessibilité commune et des aides particulières

L'amélioration générale d'un environnement bénéficie à de nombreuses personnes, tandis que certains besoins continuent d'exiger une réponse individuelle. Une information écrite plus claire aide de nombreux lecteurs sans couvrir toutes les formes de communication. Un lieu plus calme peut rester inaccessible à une personne qui a besoin d'un accompagnement. La politique collective doit combiner ce qui devient plus facile pour beaucoup et ce qui demande des moyens spécifiques.

Il faut aussi regarder qui profite réellement d'un dispositif. Une procédure numérique peut faciliter une démarche pour les personnes à l'aise avec l'écrit et les outils informatiques, tout en ajoutant des obstacles pour d'autres. Un service ne devient pas accessible parce qu'il a changé de support. Son évaluation doit inclure ceux qui l'utilisent difficilement ou qui abandonnent avant la fin. Sinon, la satisfaction des usagers restants peut masquer l'exclusion de ceux qui n'ont pas pu participer.

Cette attention aux absents vaut pour la recherche et le débat public. Les personnes disponibles pour répondre longuement à une enquête ou raconter leur expérience dans un média ne représentent pas toutes les situations. Les besoins de soutien importants, les difficultés de communication et les contraintes matérielles peuvent réduire cette présence. Il faut rechercher des moyens de participation adaptés et reconnaître les limites de ce que l'on a pu recueillir.

D'autres situations exigent des moyens importants. Un accompagnement humain, des soins spécialisés, du matériel adapté ou une réduction durable de la charge de travail ont un coût. Reconnaître ce coût fait partie d'une discussion adulte sur l'inclusion. Le nier fragilise les politiques qui prétendent y répondre. La question devient celle des priorités collectives, de l'équité et de la manière dont une société répartit les efforts nécessaires pour garantir la participation.

Le travail humain du soutien

L'aide repose souvent sur une continuité discrète. Une personne connaît les repères qui rassurent, prépare une transition ou remarque un changement inhabituel. Si elle s'absente, une partie du fonctionnement quotidien peut devenir plus difficile. Une politique sérieuse doit prévoir des relais et une transmission des informations utiles. Le soutien ne devrait pas dépendre entièrement de la mémoire et de la disponibilité d'un proche unique.

Les proches ont eux aussi des besoins, des limites et des projets, qui font partie de la soutenabilité de l'aide. Lorsqu'un soutien devient intenable, l'ensemble de la situation se fragilise. La question collective porte sur les moyens de stabiliser cette relation grâce à des professionnels formés, du répit lorsque cela est pertinent et une continuité assez fiable pour que chacun puisse prévoir sa vie.

Les ressources disponibles imposent parfois des délais et des choix. Les arbitrages devraient alors rendre visibles les besoins laissés en attente, les personnes qui supportent ce coût et les critères de priorité. Un discours général sur l'inclusion peut coexister avec des démarches si lourdes qu'elles favorisent ceux

qui disposent déjà du temps et de l'aide nécessaires. Décrire ces obstacles administratifs relève du même travail que l'analyse des obstacles sensoriels ou cognitifs.

Le langage des forces mérite une dernière vigilance. Une personne handicapée n'a pas à justifier son soutien par un talent extraordinaire. Certains individus possèdent des compétences remarquables, d'autres des capacités ordinaires, d'autres encore ont besoin d'aide dans de nombreux domaines. La dignité et l'accès aux droits reposent sur la personne et ses besoins.

Un argument économique peut appuyer une adaptation lorsqu'elle améliore aussi l'organisation. Il devient trop étroit si la rentabilité conditionne la reconnaissance d'un besoin. Certaines personnes nécessitent un accompagnement important sans produire de gain mesurable pour l'institution. Le soutien peut alors être défendu à partir de valeurs assumées ici, notamment la dignité, la solidarité et la participation. Les compétences particulières, lorsqu'elles existent, n'ont pas à servir de contrepartie morale à ce soutien.

Les diagnostics restent utiles pour organiser des soins, soutenir la recherche et rendre certains besoins visibles. Leur portée s'arrête lorsqu'une catégorie devient un scénario préécrit. Une réponse collective peut s'appuyer sur cette information sans en déduire un portrait complet de la personne.

Revenir aux personnes

Nora, Malik, Élise, Thomas, Sofia, Idriss, Léo, Lina, Camille, Ana, Jeanne et Amine sont des personnages fictifs. Ils ont permis d'examiner des questions différentes sans fabriquer des témoignages. Aucun n'est le représentant d'une catégorie entière. Leurs scènes auront rempli leur rôle si elles rendent le lecteur plus attentif aux informations qui manquent lorsqu'il rencontre une personne réelle.

Une réussite ou un échec observé sur le moment décrit seulement une partie du fonctionnement. Le travail de préparation, la condition qui a changé et l'aide disponible peuvent modifier le sens de la scène. Certaines difficultés persistent après un effort raisonnable d'adaptation. L'attention

au contexte consiste à les situer dans la vie où elles prennent place et à chercher les réponses encore possibles.

La question initiale peut maintenant être formulée avec plus de précision. Une partie du retentissement dépend des exigences et des appuis d'un milieu. L'importance de cette part varie selon les personnes, les activités et les moments. Pour l'étudier, il faut des observations et des recherches qui acceptent de rencontrer des résultats inattendus. Certaines modifications aideront beaucoup. D'autres laisseront des besoins importants auxquels il faudra répondre autrement.

Le livre défend une manière de poursuivre ce travail. Les connaissances cliniques peuvent orienter l'enquête, la parole des personnes en préciser les priorités et l'examen des institutions rendre visibles des obstacles modifiables. La coopération entre ces regards exige de renoncer à une explication totale. Elle permet de construire des réponses assez précises pour être essayées, discutées et corrigées, à mesure que les personnes et leurs conditions de vie changent.

Quelques repères de vocabulaire

Les définitions suivantes reprennent les usages du livre. Elles facilitent la lecture et ne remplacent pas les définitions détaillées des classifications ou des instruments professionnels.

Aménagement. Modification des conditions d'une activité pour réduire un obstacle identifié. Son intérêt dépend de l'objectif, de la personne et des effets réellement observés. Il peut concerner les consignes, le rythme, l'environnement matériel ou l'aide disponible.

Architecture mentale. Métaphore de travail définie dans l'avant-propos. Elle sert à parler d'un agencement mobile de capacités, de contraintes et d'appuis.

Camouflage. Ensemble de stratégies étudiées notamment dans l'autisme pour rendre moins visibles certaines particularités ou répondre aux attentes sociales. Le terme recouvre plusieurs méthodes de description et ne s'applique pas automatiquement à tout effort d'adaptation. [16]

Cartographie fonctionnelle. Proposition descriptive de ce livre. Elle rassemble des informations sur une activité, ses conditions, les aides, le coût et les priorités de la personne. Elle ne produit ni score global ni conclusion diagnostique.

CIF. Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l'OMS. Elle fournit un cadre pour décrire le fonctionnement dans son contexte, notamment en tenant compte de l'environnement. [2]

CIM. Classification internationale des maladies de l'OMS. Sa onzième révision comporte des catégories consacrées aux troubles mentaux, comportementaux et neurodéveloppementaux. Les exigences cliniques propres à un diagnostic doivent être examinées dans leur détail. [3]

Comorbidité. Coexistence de plusieurs troubles chez une personne. Le terme décrit une association et ne démontre pas que leurs causes seraient indépendantes ou entièrement communes.

Compensation. Stratégie ou aide permettant de réaliser une activité malgré une difficulté. Elle peut être choisie, efficace et peu coûteuse, ou demander un effort important. Son coût doit être décrit séparément du résultat obtenu.

Diagnostic différentiel. Examen des autres explications cliniques possibles des manifestations observées. Certaines conditions peuvent aussi être associées au trouble envisagé, ce qui rend l'évaluation plus complexe. [4]

Dimension. Aspect du fonctionnement décrit ou mesuré selon un degré, plutôt que par la seule appartenance à une catégorie. Le choix d'une dimension et la qualité de sa mesure demandent une justification.

Fonctions exécutives. Ensemble de processus qui contribuent à organiser une action orientée vers un but, notamment maintenir une information utile, inhiber une réponse ou changer de stratégie. Une difficulté dans ce domaine ne désigne pas à elle seule un diagnostic. [4]

Handicap. Dans le cadre mobilisé ici, il se comprend à partir des interactions entre un état de santé et des facteurs personnels et environnementaux. La description de ces interactions ne constitue pas une décision administrative sur l'accès à des droits. [22]

Haut potentiel intellectuel. Expression rattachée à des aptitudes cognitives élevées évaluées par des méthodes psychométriques. Elle ne définit pas à elle seule un profil émotionnel, une personnalité ou une explication générale de la souffrance. [14]

Neurodivergent. Terme dont le périmètre varie selon les usages collectifs et individuels. Il ne remplace pas une catégorie clinique définie. Son emploi demande de préciser le sens qu'on lui donne. [1]

Neurodiversité. Diversité des fonctionnements neurologiques et cognitifs humains. Le mot désigne aussi, selon les contextes, des approches du handicap et des mouvements sociaux qui ne se confondent pas avec ce premier sens descriptif. [1]

Retentissement. Conséquences concrètes d'une difficulté sur des activités, des relations, l'autonomie ou d'autres domaines de

vie. Il demande une description située et ne se réduit pas à une performance scolaire ou professionnelle.

Soutenabilité. Possibilité de maintenir une activité ou une stratégie dans le temps, en tenant compte de l'effort, de la récupération et des autres aspects de la vie. Le terme exprime ici une question d'analyse, sans seuil clinique propre.

Transdiagnostique. Approche qui étudie des caractéristiques ou des processus pouvant traverser plusieurs catégories diagnostiques. Elle peut contribuer à la recherche sans remplacer les diagnostics utilisés en clinique. [21]

Repères de lecture des sources

Les références numérotées renvoient aux publications et recommandations utilisées dans le livre. Leur fonction varie : une classification définit des catégories, une recommandation organise des pratiques, une étude examine une question dans une population donnée et une synthèse rassemble plusieurs travaux.

Les scènes personnelles sont fictives. La cartographie fonctionnelle et les propositions d'organisation relèvent de l'analyse développée ici. Le dernier chapitre formule des choix collectifs argumentés, distincts des résultats scientifiques cités. La bibliographie reste sélective et privilégie les sources directement utiles au raisonnement. Les pages institutionnelles peuvent évoluer. Leurs dates ont été vérifiées pour cette version en septembre 2026.

Bibliographie

[1] Dwyer, Patrick. The Neurodiversity Approach(es): What Are They and What Do They Mean for Researchers? *Human Development*, 2022, 66(2), pages 73 à 92. Article conceptuel. DOI 10.1159/000523723. Consulter la source

[2] Organisation mondiale de la santé. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Cadre adopté en 2001. Présentation officielle de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. Consulter la source

[3] Organisation mondiale de la santé. Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders. Genève, OMS, 2024. Référence de classification clinique. Consulter la source

[4] Haute Autorité de santé. Trouble du neurodéveloppement / TDAH : diagnostic et interventions thérapeutiques auprès des enfants et adolescents. Recommandations, juillet 2024. Voir notamment les sections consacrées à l'évaluation clinique, aux diagnostics différentiels et aux interventions. Consulter la source

[5] National Institute for Health and Care Excellence. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management. Recommandation NG87, publiée en 2018 et modifiée ultérieurement. Voir les sections 1.3 sur le diagnostic et 1.5 sur la prise en charge. Consulter la source

[6] National Institute of Mental Health. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: What You Need to Know. Présentation institutionnelle des manifestations, de l'évaluation et des traitements du TDAH. Consulter la source

[7] Centers for Disease Control and Prevention. ADHD in Adults. Présentation institutionnelle de l'évolution des manifestations et des besoins à l'âge adulte. Consulter la source

[8] Organisation mondiale de la santé. Autism. Fiche institutionnelle sur l'autisme, les capacités et les besoins de soutien. Consulter la source

[9] National Institute for Health and Care Excellence. Autism spectrum disorder in adults: diagnosis and management. Recommandation CG142, publiée en 2012 et modifiée ultérieurement. Évaluation globale, besoins de communication et recherche de problèmes de santé associés. Consulter la source

[10] Crompton, Catherine J., et ses collègues. Autistic peer-to-peer information transfer is highly effective. *Autism*, 2020, 24(7), pages 1704 à 1712. Étude expérimentale. DOI 10.1177/1362361320919286. Consulter la source

[11] Cusson, Noémie M., et ses collègues. A systematic review and meta-analysis of empathy in autism: The influence of measures. *Clinical Psychology Review*, 2025, 120, article 102623. DOI 10.1016/j.cpr.2025.102623. Consulter la source

[12] National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Developmental Language Disorder. Fiche institutionnelle, actualisée en 2023. Définition, manifestations et conséquences des difficultés langagières. Consulter la source

[13] National Health Service. Dyspraxia in adults. Présentation institutionnelle du trouble développemental de la coordination et de ses conséquences quotidiennes. Consulter la source

[14] Tasca, Ilaria, et ses collègues. Behavioral and Socio-Emotional Disorders in Intellectual Giftedness: A Systematic Review. *Child Psychiatry & Human Development*, 2024, 55(3), pages 768 à 789. Première publication en ligne en 2022. DOI 10.1007/s10578-022-01420-w. Consulter la source

[15] Greven, Corina U., Trupp, MacKenzie D., Homberg, Judith R., et Slagter, Heleen A. Sensory processing sensitivity: theory, evidence, and directions. *Trends in Cognitive Sciences*, 2026, 30(6), pages 530 à 545. Publication en ligne le 3 novembre 2025. DOI 10.1016/j.tics.2025.10.007. Consulter la source

[16] Cook, Julia, Hull, Laura, Crane, Laura, et Mandy, William. Camouflaging in autism: A systematic review. *Clinical Psychology Review*, 2021, 89, article 102080. DOI 10.1016/j.cpr.2021.102080. Consulter la source

[17] Raymaker, Dora M., et ses collègues. Having All of Your Internal Resources Exhausted Beyond Measure and Being Left with No Clean-Up Crew: Defining Autistic Burnout. *Autism in Adulthood*, 2020, 2(2), pages 132 à 143. Étude qualitative. DOI 10.1089/aut.2019.0079. Consulter la source

[18] Lovett, Benjamin J., et Nelson, Jason M. Systematic Review: Educational Accommodations for Children and Adolescents With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 2021, 60(4), pages 448 à 457. DOI 10.1016/j.jaac.2020.07.891. Consulter la source

[19] Leifler, Emma, et ses collègues. Does the learning environment ‘make the grade’? A systematic review of accommodations for children on the autism spectrum in mainstream school. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 2021, 28(8), pages 582 à 597. DOI 10.1080/11038128.2020.1832145. Consulter la source

[20] Heinze, Cécile. Workplace Accommodations and Employment Outcomes Among Employees With Autism: A Systematic Review. *Cureus*, 2025, 17(12), article e99353. Publié le 16 décembre 2025. DOI 10.7759/cureus.99353. Consulter la source

[21] National Institute of Mental Health. About RDoC. Présentation institutionnelle du programme Research Domain Criteria et de sa fonction de recherche. Consulter la source

[22] Organisation mondiale de la santé. Disability and health. Fiche institutionnelle consacrée au handicap et aux interactions avec les facteurs personnels et environnementaux. Consulter la source

[23] National Health Service. Dyslexia in children. Fiche institutionnelle, dernière révision le 11 mars 2026. Description des difficultés de lecture et d’orthographe et de l’évaluation dans le contexte britannique. Consulter la source

[24] Petruzzelli, Maria Giuseppina, et ses collègues. An update on the comorbidity of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorder (ASD) and its clinical management. *Expert Review of Neurotherapeutics*, 2026, 26(1), pages 75 à 89. Publication en ligne le 12 décembre 2025. DOI 10.1080/14737175.2025.2599856. Consulter la source

[25] Crompton, Catherine J., et ses collègues. Information transfer within and between autistic and non-autistic people. *Nature Human Behaviour*, 2025, 9, pages 1488 à 1500. Étude de réplication et d’extension avec protocole enregistré. DOI 10.1038/s41562-025-02163-z. Consulter la source